#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

GERMAS
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

LAPORAN RTP

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL

TAHUN 2027







Sehat Masyarakatnya Kuat Kotanya

KATA PENGANTAR

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan kesehatan harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan, maka perlu upaya pengendalian faktor resiko terjadinya kegagalan pelaksanaan kegiatan. Untuk itu disusunlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Tegal Tahun 2026.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Tegal Tahun 2026 ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran guna perbaikan senantiasa kami harapkan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT sajalah kita berlindung dan berserah diri. Seiring permohonan semoga upaya kita dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud dan mendapat rahmat, hidayah dan ridho-Nya. Amiin.

Tegal, Oktober 2026
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal

M. ZAENAL ABIDIN, SKM, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680514 198801 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi dibidang keuangan negara dengan mengacu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas Kesehatan Kota Tegal sebagai salah satu OPD pada Pemerintah Kota Tegal, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Atas dasar tersebut, Dinas Kesehatan Kota Tegal akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tegal dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

2. Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tegal

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal, Dinas Kesehatan termasuk perangkat daerah dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.

Menurut Peraturan Walikota Tegal Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Kesehatan Kota Tegal, Dinas Kesehatan Kota Tegal merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan Kota Tegal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan
c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan, Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan;
d. pembinaan dan fasilitasi di bidang kesehatan;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
f. pengendalian administrasi kesekretariatan Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tegal menurut Peraturan Peraturan Walikota Tegal Nomor 34 Tahun 2023 terdiri dari :

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Kesehatan.

2. Sekretariat

   Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilingkup perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian, serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.

   Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab pada Kepala Dinas Kesehatan, yang mempunyai fungsi:

   1). pengoordinasian penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas.
   2). perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas.
   3). pengoordinasian pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas.
   4). pengoordinasian penyiapan bahan tanggapan atas hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan;
   5). pengoordinasian pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di

lingkungan Dinas.

6). pengoordinasian pengelolaan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga dan barang milik daerah di lingkungan Dinas.

7). pengoordinasian penata kelolaan organisasi, tata laksana dan pelayanan publik di lingkungan Dinas.

8). pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.

9). pengoordinasian penyusunan konsep kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas.

10). pengoordinasian penyusunan evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas.

11). pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi serta dokumentasi di lingkungan Dinas.

12). pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas.

13). pengoordinasian pelaksanaan evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas.

14). pengoordinasian penyusunan laporan capaian kinerja di lingkungan Dinas.

15). pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesekretariatan Dinas.

16). pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu:

1). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan di lingkungan Dinas.

2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas

3. Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan

Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan penyakit, serta pelayanan kesehatan.

Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, yang mempunyai fungsi:

1). penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan;
2). perumusan kebijakan teknis kesehatan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan penyakit, serta pelayanan kesehatan;
3). pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis kesehatan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan penyakit, serta pelayanan kesehatan;
4). pengoordinasian pengelolaan upaya kesehatan ibu hamil dan bersalin;
5). pengoordinasian pengelolaan upaya kesehatan bayi baru lahir dan balita;
6). pengoordinasian pengelolaan upaya kesehatan pada usia pendidikan dasar, usia produktif dan usia lanjut;
7). pengoordinasian pengelolaan upaya kesehatan gizi masyarakat;
8). pengoordinasian pengelolaan upaya kesehatan kerja dan olahraga;
9). pengoordinasian pengelolaan upaya kesehatan lingkungan;
10). pengoordinasian pelaksanaan pembinaan upaya kesehatan anak, remaja, ibu, usia lanjut, institusi dan lingkungan serta perbaikan gizi masyarakat;
11). pengoordinasian penyelenggaraan kota sehat;
12). pengoordinasian pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi dan diabetes melitus;
13). pengoordinasian pengelolaan pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa berat, orang dengan masalah kesehatan jiwa dan orang dengan penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
14). pengoordinasian pengelolaan pelayanan kesehatan bagi orang terduga tuberkolosis dan orang dengan resiko terinfeksi human immunodeficiency virus;
15). pengoordinasian pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa;

16). pengoordinasian pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana;
17). pengoordinasian pengelolaan surveilans kesehatan;
18). pengoordinasian pengelolaan upaya kesehatan khusus;
19). pengoordinasian pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan;
20). pengoordinasian pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular;
21). pengoordinasian pelaksanaan deteksi dini penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan dan sekolah;
22). pengoordinasian pelaksanaan kegiatan imunisasi;
23). pengoordinasian pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, penyakit menular tidak langsung dan penyakit bersumber binatang;
24). pengoordinasian pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
25). pengoordinasian pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa ke laboratorium rujukan/nasional;
26). pengoordinasian pelaksanaan investigasi awal kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal;
27). pengoordinasian pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah;
28). pengoordinasian pembinaan surveilans pada sarana kesehatan;
29). pengoordinasian pengamatan, pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan akibat bencana, keracunan dan wabah;
30). pengoordinasian pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya;
31). pengoordinasian pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat;
32). pengoordinasian penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan;
33). pengoordinasian pengelolaan penelitian kesehatan;
34). pengoordinasian pembinaan operasional pelayanan kesehatan pada rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya;
35). pengoordinasian pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di daerah yang menjadi kewenangan;

36). pengoordinasian penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan;
37). pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan; dan
38). pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan dibantu oleh Pejabat fungsional dan pelaksana.

4. Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan, perizinan fasilitas pelayanan kesehatan serta kefarmasian, alat kesehatan, makanan dan minuman.

Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, yang mempunyai fungsi:

1). penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2). perumusan kebijakan teknis sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan, perizinan fasilitas pelayanan kesehatan serta kefarmasian, alat kesehatan, makanan dan minuman;
3). pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan, perizinan fasilitas pelayanan kesehatan serta kefarmasian, alat kesehatan, makanan dan minuman;
4). pengoordinasian pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya;
5). pengoordinasian pembangunan puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya;
6). pengoordinasian pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan;
7). pengoordinasian pengembangan rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya;
8). pengoordinasian rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan lainnya dan rumah dinas tenaga kesehatan;
9). pengoordinasian pengadaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas

pelayanan kesehatan;

10). pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan;
11). pengoordinasian pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan;
12). pengoordinasian pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan;
13). pengoordinasian pengelolaan data dan informasi kesehatan;
14). pengoordinasian pengelolaan sistem informasi kesehatan;
15). pengoordinasian pengadaan alat/perangkat penunjang sistem informasi kesehatan;
16). pengoordinasian penerbitan rekomendasi perizinan fasilitas kesehatan tingkat pertama, klinik utama, rumah sakit kelas c dan d tingkat daerah kota;
17). pengoordinasian pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
18). pengoordinasian peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kota;
19). pengoordinasian penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan;
20). pengoordinasian pengelolaan perbekalan kesehatan meliputi perencanaan kebutuhan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai, regensia, dan alat kesehatan lainnya;
21). pengoordinasian pengadaan dan pemeliharaan peralatan kalibrasi alat kesehatan;
22). pengoordinasian pelaksanaan kalibrasi dan pemeliharaan alat kesehatan;
23). pengoordinasian pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal serta usaha mikro obat tradisional;
24). pengoordinasian pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal serta usaha mikro obat tradisional;
25). pengoordinasian fasilitasi pemenuhan komitmen izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal serta usaha mikro obat tradisional;

26). pengoordinasian pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga;

27). pengoordinasian pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor produk industri rumah tangga sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga;

28). pengoordinasian pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum;

29). pengoordinasian pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan;

30). pengoordinasian pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan;

31). pengoordinasian pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga;

32). pengoordinasian penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

33). pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan

34). pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan tugas teknis fungsional sesuai ruang lingkup fungsi Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pelaksana.

5. Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan

Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perizinan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, yang mempunyai fungsi:

1). penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan;
2). perumusan kebijakan teknis perizinan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
3). pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perizinan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
4). pengoordinasian pengendalian penerbitan perizinan praktik tenaga kesehatan di wilayah kota;
5). pengoordinasian pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan di wilayah kota;
6). pengoordinasian penyusunan rencana pemerataan distribusi sumber daya manusia kesehatan;
7). pengoordinasian pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar;
8). pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan;
9). pengoordinasian pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat kota;
10). pengoordinasian peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan;
11). pengoordinasian penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
12). pengoordinasian pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
13). pengoordinasian pengembangan media promosi kesehatan;
14). pengoordinasian pembinaan upaya kesehatan di institusi pendidikan;
15). pengoordinasian pembinaan organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam bidang kesehatan;
16). pengoordinasian penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran

Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan;

17). pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan

18). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang melaksanakan tugas teknis fungsional sesuai ruang lingkup fungsi Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan.

6. Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK)

RSUD Kardinah merupakan UOBK yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

7. Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF)

Pada Dinas Kesehatan terdapat pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) sebagai UOBF yang memberikan layanan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah

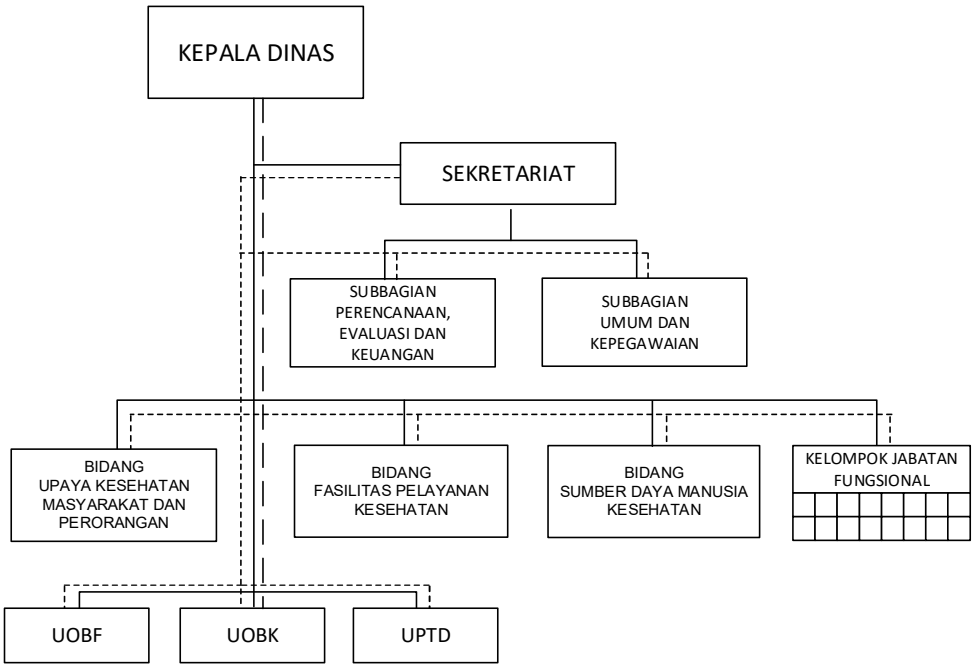
Unit Pelaksana Teknis Daerah melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai bidang masing-masing, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yaitu Klinik Paru Masyarakat (KPM), Laboratorium Kesehatan, Instalasi Farmasi Dan Perbekalan Kesehatan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian atau Kepala UPTD yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL



3. Dasar Hukum

Dasar penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Intern adalah:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
b. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
c. Peraturan Walikota Tegal Nomor 81 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 81).
d. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal

4. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektivitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/ terpasang serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas

Kesehatan Kota Tegal, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tegal dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Kesehatan Kota Tegal.

5. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan - kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di internal Satuan Tugas SPIP Dinas Kesehatan Kota Tegal. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tegal. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam Tahun 2027.

6. Manfaat

Keberadaan Rencana Tindak Pengendalian Intern ini diarahkan untuk menjadi landasan/dasar dalam hal:

a. Pengembangan SPIP secara menyeluruh.
b. Perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPIP.
c. Pendokumentasian, pemantauan, dan pengukuran perkembangan/program.

BAB II
PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh para penyelenggara pelayanan publik sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada para penyelenggara pelayanan publik menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan / *fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar sistem pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif.

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

a. Penegakan integritas dan nilai etika.
b. Komitmen terhadap kompetensi.
c. Kepemimpinan yang kondusif.

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif.
h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis risiko) serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan untuk :

a. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal.
b. Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yang terdiri atas :

a. Penetapan tujuan organisasi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan ativitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
b. Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko.
c. Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanaan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian *existing*.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokan dalam dua kategori, yaitu *preventif* dan *mitigasi*. Pengendalian yang bersifat *preventif* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigasi* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan- perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu:

a. Pemantauan Berkelanjutan

   Kegiatan monitoring terhadap kualitas kinerja pengendalian intern yang dilaksanakan secara terus menerus dan menyatu dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, dengan menggunakan kriteria pemantauan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, seperti kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, *Standard Operating Procedurs*, dan lain-lain. Tujuan pemantauan berkelanjutan adalah untuk memastikan bahwa pengendalian intern telah berfungsi sebagaimana yang diharapkan, dan apabila terdapat kelemahan atau kegagalan pengendalian, dapat segera ditemukan penyebabnya dan dilakukan perbaikan seperlunya.

b. Evaluasi Terpisah

   Kegiatan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern yang dilaksanakan melalui kegiatan pembandingan antara pelaksanaan pengendalian intern dengan standar yang telah ditetapkan, serta menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk memperbaiki atau meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern. Kriteria yang menjadi sebagai acuan evaluasi tidak berbeda dengan kriteria pemantauan berkelanjutan, yaitu kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, *Standard Operating Procedurs*, dan lain- lain. Kegiatan evaluasi terpisah dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu, baik dilaksanakan secara mandiri maupun oleh evaluator independen dari luar organisasi.

c. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit

   Pelaksanaan audit, baik oleh Inspektorat maupun BPK-RI, merupakan salah satu fungsi manajemen dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Pelaksanaan audit atau reviu lainnya akan menghasilkan rekomendasi perbaikan atas kelemahan penyelenggaraan kegiatan organisasi. Pimpinan organisasi harus

tanggap dan segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil kegiatan audit atau reviu lainnya, agar efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern semakin kuat.

Untuk terwujudnya penyelenggaraan SPIP yang efektif, maka seluruh unsur SPIP tersebut harus diterapkan secara terintegrasi dengan aktivitas organisasi, agar mampu mencegah timbulnya kegagalan dan ketidak efisienan dalam pencapaian tujuan organisasi.

BAB III
PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Penerapan SPIP di Dinas Kesehatan Kota Tegal

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri / pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati / wali kota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Dalam kaitan dengan pengendalian intern tersebut, Walikota Tegal telah menerbitkan Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, yang memuat petunjuk pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada seluruh kegiatan pemerintahan di Kota Tegal.

1. Evaluasi Lingkungan Pengendalian/Control Environment Evaluation (CEE)

Tujuan CEE adalah untuk mengevaluasi kondisi lingkungan pengendalian yang ada pada suatu organisasi dibandingkan dengan “kondisi ideal” (*framework*) dari masing-masing sub unsur dalam lingkungan pengendalian dan sebagai bahan bagi manajemen dalam perbaikan lingkungan pengendalian.

Metode yang dilakukan dalam CEE adalah menggunakan media kuesioner dan melakukan validasi atas jawaban persepsi CEE dari pegawai Dinas Kesehatan Kota Tegal sebagai responden yang terdiri dari unsur pejabat struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum/staf.

Langkah atau tahapan dalam melakukan CEE sebagai berikut :

a. Menyiapkan kuesioner CEE atas 8 (delapan) sub unsur Lingkungan Pengendalian.
b. Menentukan sampel pegawai yang dijadikan responden.
c. Melakukan tabulasi atas jawaban responden dengan menggunakan aplkasi excell.
d. Melakukan rekapitulasi jawaban dan penilaian CEE atas kuesioner evaluasi lingkungan pengendalian, berdasarkan modus jawaban responden.
e. Melakukan validasi atas hasil penilaian berdasarkan modus jawaban responden.

f. Membuat kesimpulan hasil penilaian atas 8 (delapan) unsur Lingkungan Pengendalian yang ada dengan empat kategori yaitu “Memadai, Cukup Memadai, Belum Memadai dan Tidak Memadai” dari hasil aplikasi Excell.
g. Menyusun rencana tindak pengendalian (RTP) atas sub unsur dan sub- sub unsur lingkungan pengendalian yang “Tidak Memadai dan Kurang Memadai”, berikut penetapan waktu dan penanggungjawab kegiatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampumendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
h. Melakukan Evaluasi secara berkala terhadap RTP Lingkungan Pengendalian yang telah disusun.

2. **Penilaian Risiko**

Penilaian Risiko pada Dinas Kesehatan Kota Tegal dilakukan Pemetaan Risiko terhadap kegiatan utama yang menunjang pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota Tegal yang tertuang dalam Rencana Straegis Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2029.

Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis risiko) serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan untuk:

a. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal;
b. Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Metode yang dilakukan dalam penilaian risiko atas kegiatan utama adalah menggunakan Metode Penyusunan RTP (*Focus Group Discussion* / FGD) dengan melibatkan pegawai Dinas Kesehatan Kota Tegal sebagai responden yang terdiri dari unsur unsur pejabat struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum / staf.

Langkah atau tahapan dalam melakukan penilaian risiko atas kegiatan utama sebagai berikut :

a. Menetapkan Daftar Tujuan Kegiatan yang berisi rumusan tujuan dan sasaran serta Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tegal, Kegiatan yang mendukung capaian Sasaran Perangkat Daerah dan rumusan tujuan kegiatan.
b. Menyusun Daftar Resiko Kegiatan yang mendukung capaian Sasaran Perangkat Daerah beserta dampak jika risiko terjadi.

c. Melakukan analisa risiko dengan menggunakan formulir analisis risiko yang berisi pernyataan risiko, skor kemungkinan dan dampak untuk menentukan skor status risiko.
d. Melakukan identifikasi risiko dengan menggunakan formulir identifikasi pengendalian yang berisi :
    1) Risiko Strategis Pemda,
    2) Risiko Strategis OPD,
    3) Risiko Operasional OPD,
    4) Identifikasi Risiko Strategis Pemda,
    5) Identifikasi Risiko Strategis OPD,
    6) Identifikasi Risiko Operasional OPD,
    7) Kertas Kerja Hasil Analisa Risiko,
    8) Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas,
    9) Rencana Tindak Pengendalian atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian.

Hasil kegiatan pengisian formulir identifikasi tersebut selanjutnya dijadikan sebagai landasan awal untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pengendalian intern (menyusun Rencana Tindak Pengendalian).

B. Hasil Identifikasi Risiko

1. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya system pengendalian intern ecara efektif di Dinas Kesehatan Kota Tegal.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di Dinas Kesehatan Kota Tegal bertujuan untuk :

a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;

f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
g. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif;
h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

2. **Proses Evaluasi Lingkungan Pengendalian**

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di Dinas Kesehatan Kota Tegal Tahun 2027, diperoleh gambaran sebagai berikut :

No	Sub Unsur	Kondisi (*)
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	*Memadai*
2	Komitmen terhadap Kompetensi	*Memadai*
3	Kepemimpinan yang Kondusif	*Memadai*
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	*Memadai*
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	*Kurang Memadai*
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	*Memadai*
7	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif	*Memadai*
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	*Memadai*

3. **Perumusan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Kesehatan Kota Tegal menginginkan terciptanya lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hasil skoring 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian dengan hasil “Memadai”. Akan tetapi berdasarkan hasil riviu dokumen diketahui bahwa ada 7 (tujuh) sub unsur lingkungan pengendalian yang “Memadai” dan 1 (satu) sub unsur lingkungan kurang memadai yaitu sub unsur Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat.

Terhadap kelemahan lingkungan pengendalian yang ada akan segera dilakukan perbaikan, yaitu :

a. Sub unsur Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat
   1). Menginput perubahan target IKU sesuai dengan perjanjian kinerja pada sistem informasi emonev
   2). Mengajukan Draft usulan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan dan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan kepada Bagian Organisasi Setda Kota Tegal
   3). Mengajukan Draft usulan Perubahan Perubahan Pohon Kinerja Dinas Kesehatan kepada Bagian Organisasi Setda Kota Tegal
   4). Mengajukan Draft usulan Perubahan Crosscutting Dinas Kesehatan kepada Bagian Organisasi Setda Kota Tegal.

C. Hasil Analisis Risiko

Analisa Risiko dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu Risiko Strategis OPD dan Risiko Operasional OPD. Hasil dari analisis sebagai berikut :

1. Analisa Risiko Strategis OPD

   Pada kategori Risiko Strategis OPD ada 3 (tiga) risiko yang menjadi risiko prioritas yaitu Keterlambatan ibu hamil dalam mendapatkan pelayanan K6, Target penurunan prevalensi gizi buruk tidak tercapai, Tingkat penemuan kasus TBC baru secara aktif (Case Detection Rate) rendah.

   a. Keterlambatan ibu hamil dalam mendapatkan pelayanan K6

      Pelayanan K6 merupakan kunjungan kehamilan keenam (K6) dalam layanan kesehatan ibu hamil, yaitu pemeriksaan minimal enam kali selama kehamilan (1x trimester pertama, 2x trimester kedua, dan 3x trimester ketiga). Beberapa faktor yang mempengaruhi cakupan pelayanan K6 (Kunjungan pemeriksaan ibu hamil ke-6) yaitu faktor ibu hamil dan faktor sistem pelayanan kesehatan. Faktor yang mempengaruhi pelayanan K6 dapat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari ibu hamil yang bersangkutan yaitu kurangnya pengetahuan ibu tentang pentingnya *Antenatal Care* (ANC), tingkat pendidikan yang rendah, dan faktor ekonomi seperti kepesertaan dana atau asuransi kesehatan. Adapaun faktor eksternal berasal dari sistem pelayanan kesehatan seperti keterbatasan akses baik jarak maupun kondisi geografis, kurangnya penyuluhan yang efektif, peran aktif dari petugas kesehatan, serta dukungan dari keluarga, tokoh masyarakat, dan pemerintah.

Pelayanan kesehatan Ibu hamil secara standar atau sering disebut dengan ANC di lakukan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya, dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam standar pelayanan kebidanan. Dalam melaksanakan pelayanan ANC, ada sepuluh standar pelayanan yang harus dilakukan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang dikenal dengan 10 T. Pelayanan atau asuhan standar minimal 10 T yaitu timbang berat badan, ukur tinggi badan, ukur lingkar lengan atas, ukur tinggi fundus uteri, cek tekanan darah, pemeriksaan presentasi janin dan denyut jantung janin, skrining status imunisasi tetanus, pemberian tablet zat besi, tes laboratorium dan konseling.

Pelayanan ibu hamil dimaksudkan untuk menjaga kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya. Pemerintah sangat upaya agar tidak terjadi kematian ibu dan kematian bayi maupun balita. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal antara lain ANC Terpadu, Kelas Ibu hamil, Pemberian PMT Ibu hamil, Melakukan Skrining SHK, Jaminan biaya kesehatan bagi keluarga tidak mampu, Kunjungan ibu hamil risiko tinggi, Menyediakan puskesmas mampu mampu persalinan dan RS rujukan PONEK, Pendampingan dokter spesialis kandungan (SPOG) dan dokter speasialis anak (SPA), Pendampingan rujukan ibu hamil risiko tinggi dan neonatal risti. Upaya lain akan dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan layanan ibu hamil yaitu pendampingan dokter yang terlatih USG dalam pemeriksaan ibu hamil. Ibu hamil minimal 2 kali diperiksa USG pada awal kehamilan dan trimester 3. Diharapkan kondisi ibu dan janin yang dikandungnya dapat terpantau kondisi kesehatannya sejak dini.

Dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu mengenai kehamilan, persalinan, perawatan nifas, dan perawatan bayi baru lahir agar kehamilan dan persalinan berjalan lancar, serta untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Dinas Kesehatan Kota Tegal mengadakan Kelas Ibu Hamil. Diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat meningkatkan cakupan K6 dan pada akhirnya tidak ada kematian ibu dan bayi.

b. Target penurunan prevalensi gizi buruk tidak tercapai

Target penurunan prevalensi gizi buruk tidak tercapai disebabkan oleh komposit beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor lingkungan, dan faktor kesehatan. Faktor ekonomi seperti kemiskinan dan pendapat yang rendah berkonstribusi pada terjadinya gizi buruk karena akses terhadap

makanan yang bergizi sangat minim, sehingga intake makanan terhadap balita kurang memenuhi sehingga dapat menyebabkan gizi buruk. Adapun faktor ekonomi berpengaruh terhdap kejadian gizi buruk terait dengan kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi seimbang dan tingkat pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah berpengaruh terhadap pengetahuan tentang makanan gizi seimbang yang kurang yang berakibat pada praktik pemberian gizi seimbang yang kurang juga. Disamping itu juga pengetahuan yang rendah juga berpengaruh pada pola pemberian dan olahan pangan untuk balita yang kurang. Sehingga dalam pemberian makana tidak ada variasi olahan makanan tersebut yang berakibat pada kebosanan balita ketika makan. Faktor lingkungan seperti kondisi sanitasi buruk, akses air bersih yang kurang juga berpengaruh terhadap terjadinya gizi buruk.

Faktor lain yang mempengaruhi gizi buruk yaitu kesehatan balita seperti adanya penyakit infeksi, status imunisasi dan akses layanan kesehatan. Balita yang mempunyai penyakit infeksi seperti TBC, kecacingan, penyakit jantung bawaan maupun penyakit infeksi lainnya sangat rentan terjadinya gizi buruk. Disamping itu juga status imunsasi juga berpengaruh terhadap terjadinya gizi buruk, karena balit yang tidak diimunisasi sangat rentan terjadi penykit menular yang akan memperparah kondisi tubuhnya. Akses terhadap layanan juga berpengaruh terhadap terjadinya gizi buruk. Layanan kesehatan yang jauh dari jangkauan atau kondisi ekonomi yang tidak mampu membayar layanan kesehatan atau tidak mempunyai jaminan kesehatan nasional akan berakibat susahnya akses terhadap layanan kesehatan. Hal tersebut berakibat pada kondisi kesehatan anak yang tidak segera mendapatkan layanan sehingga akan memperparah status gizinya.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka menurunkan prevalensi gizi buruk yaitu melakukan pencatatan dan validasi data balita gizi buruk melalui aplikasi Kementerian Kesehatan Ri yaitu aplikasi e-PPBGM, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di posyandu balita, pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan bagi pederita gizi buruk, kunjungan rumah balita gizi buruk oleh petugas atau kader kesehatan, pembiayaan bagi keluarga tidak mampu dengan pemberian jaminan kesehatan nasonal (JKN) PBI, melakukan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) bagi Anak Balita untuk mendeteksi penyakit jantung bawaan (PJB) lebih dini.

c. *Tingkat penemuan kasus TBC baru secara aktif (Case Detection Rate) rendah*

Risiko Strategis OPD Dinas Kesehatan yang ketiga yaitu *Tingkat penemuan kasus TBC baru secara aktif (Case Detection Rate) rendah*. TBC merupakan penyakit menular yang dapat dicegah dengan disiplin dalam pengobatan. Kondisi saat ini bahwa masyarakat di sekitar kita punya risiko tinggi terhadap penyakit TBC, akan tetapi yang bersangkutan enggan untuk periksa ke pelayanan kesehatan. Hal itu berdampak pada peningkatan kasus TBC di masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan upaya pencegahan dengan melakukan skrining aktif penemuan TBC di masyarakat maupun di pelayanan kesehatan. Penemuan kasus TBC di masyarakat juga harus dibarengi dengan pengobatan / *treatment* yang adekuat, karena jika tidak maka memungkinkan terjadinya hal lebih buruk yaitu resistensi obat yang berpotensi lebih menular dan lebih mematikan. Oleh karena ketika pasien TBC yang ditemukan harus diobati sampai tuntas selama 6 bulan sehingga yang bersangkutan dinyatakan sembuh dari penyakit TBC yang dideritanya.

Angka keberhasilan pengobatan TBC yang masih rendah menunjukkan bahwa masih tinggi kasus TB mangkir atau *Lost Follow Up* pengobatan TBC. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengurangi penderita yanarapkan g mangkir minum obat dengan pemantaun Pandamping Minum Obat (PMO) baik dari keluarga atau kader kesehatan. Disamping itu juga diperlukan upaya pelacakan kasus TB mangkir, sehingga diharapkan pasien yang mangkir minum obat diharapkan dapat kembali minum bahkan agar tidak sampai mangkir minum obat.

2. Analisa Risiko Operasional OPD

Pada kategori Risiko Operasional OPD ada 3 (tiga) risiko yang menjadi risiko prioritas yaitu Penderita ODGJ tidak berobat dan tidak minum obat secara rutin, Bayi dan balita tidak mendapatkan imunisasi lengkap dan SIMPUS tidak dapat diakses.

a. Penderita ODGJ tidak berobat dan tidak minum obat secara rutin.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatnya cakupan pencerita ODGJ yang tidak berobat dan tidak minum obat secara rutin yaitu dengan melakukan sosialisasi kesehatan jiwa, deteksi dini dan skrining kesehatan jiwa, Kunjungan Rumah kasus ODGJ, Pengobatan rutin pasien ODGJ, Penemuan kasus ODGJ baru, Pengiriman kasus ODGJ ke Rumah Sakit Rujukan dan Pembuatan KIS bagi ODGJ yang tidak mempunyai JKN.

b. Bayi dan balita tidak mendapatkan imunisasi lengkap

Upaya yang dilakukan agar abyi dan balita mendapatkan imunisasi lengkap yaitu Sosialisasi imunisasi dg berbagai media, Sosialisasi imunisasi melalui kegiatan kampanye imunisasi, Koordinasi dengan disdukcapil terkait data sasaran imunisasi, Koordinasi dan pemantauan secara berkala terhadap hasil inputan ASIK, Advokasi kepada kepala puskesmas untuk membentuk tim khusus input data di ASIK Imunisasi dan melakukan Renval dan PWS imunisasi secara berkala.

c. SIMPUS tidak dapat diakses

SIMPUS merupakan kependekan dari sistem informasi manajemen puskesmas yang merupakan aplikasi untuk mencatat seluruh rekam medis pasien yang berobat ke pelayanan kesehatan baik di puskesmas, puskemas pembantu, posyandu, prolanis. SIMPUS menjadi aplikasi yang sangat diperlukan oleh puskesmas untuk dapat memanggil kembali riwayat medis pasien sehingga akan petugas akan mengetahui riwayat obat, diagnosa, tindakan serta terapi yang telah diberikan. Kecepatan dan kelengkapan informasi dari riwayat rekam medis sebelumnya akan membantu petugas untuk menegakkan diagnosis dan terapi selanjutnya. Akses ke aplikas yang lambat atau bahkan terjadi *request time out* (RTO) menyebabkan kendala pada pelayanan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal melalui Kominfo Kota Tegal dalam rangka untuk mempercepat akses ke layanan aplikasi SIMPUS yaitu penyambungan jaringan *fiber optic* (FO) ke puskemas dan beberapa pustu, penyambungan jaringan internet dari provider lain sebagai back up apabila layanan internet dari Kominfo mengalami gangguan, maintenance berkala server oleh Kominfo, pengelolaan Cpanel pada setiap domain yang ada, pengamanan sistem dengan SSL dan Web Security untuk menjaga dari serangan virus atau hacker, melakukan update SIMPUS dan perbaikan jaringan (LAN) dengan menggunakan kabel dan router dengan kecepatan tinggi.

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk mempercepat akses ke aplikasi, akan tetapi kadang masih terjadi aplikasi lambat dan bahkan terjadi RTO yang mungkin disebabkan dari sistem aplikasi sendiri seperti manajemen *database* atau *table* yang kurang efektif. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya normalisasi dan optimalisasi manajemen *database* atau *table* sehingga akses

ke aplikasi bisa lebih cepat yang berakibat pada meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien terhadap layanan di puskesmas.

D. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan Dinas Kesehatan Kota Tegal:

1. Penguatan pelaksanaan kelas ibu hamil
2. Konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)
3. Pemeriksaan TBC di masyarakat secara aktif
4. Pendamping Minum Obat (PMO) bagi ODGJ
5. Sweeping rutin imunisasi bayi dan balita di masyarakat
6. Melakukan monitoring server tegalkota, bridging BPJS dan Satusehat secara berkala.

BAB IV
RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi :

1. Tujuan : Terwujudnya Kesehatan Untuk Semua
2. Sasaran : Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media / Bentuk Sarana Pengkomunikasian
a	b	c
1	Penguatan pelaksanaan kelas ibu hamil	Pertemuan
2	Konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	Konseling
3	Pemeriksaan TBC di masyarakat secara aktif	Pemeriksaan
4	Pendamping Minum Obat (PMO) bagi ODGJ	Petemuan
5	Sweeping rutin imunisasi bayi dan balita di masyarakat	Kunjungan Rumah
6	Melakukan monitoring server tegalkota, bridging BPJS dan Satusehat secara berkala	Monitoring

Rancangan Informasi dan Komunikasi ini idealnya dilaporkan perkembangannya secara rutin, minimal setiap 6 (enam) bulan agar dapat dilakukan evaluasi sehingga komunikasi bisa lebih efektif. Selain itu, hasil evaluasi akan digunakan sebagai bahan untuk mengambil tindakan yang bersifat prefentif terhadap kendala yang muncul untuk segera dicari solusi dan pemecahan masalahnya. Laporan sebagai bentuk evaluasi berisi hal-hal antara lain:

1. Media / Bentuk / Sarana Pengkomunikasian yang digunakan;
2. Penyedia Informasi / Penanggung jawab tindak lanjut;
3. Penerima informasi / tindak lanjut;
4. Waktu pelaksanaan;
5. Kendala / hambatan yang muncul;
6. Realisasi rencana tindak lanjut.

BAB V
RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan dan Evaluasi atas pengendalian intern ditujukan untuk memberikan keyakinan apakah Sistem Pengendalian Intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan pengendalian yang diperlukan telah dilaksanakan guna perbaikan SPI yang terpasang. Pemantauan dan Evaluasi diselenggarakan atas rencana pengendalian risiko yang masih dibutuhkan sesuai dalam daftar risiko yang dibangun dalam RTP. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Tujuan : Terwujudnya Kesehatan Untuk Semua
2. Sasaran : Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
a	b	c
1	Penguatan pelaksanaan kelas ibu hamil	Monitoring Dan Evaluasi
2	Konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	Monitoring Dan Evaluasi
3	Pemeriksaan TBC di masyarakat secara aktif	Monitoring Dan Evaluasi
4	Pendamping Minum Obat (PMO) bagi ODGJ	Monitoring Dan Evaluasi
5	Sweeping rutin imunisasi bayi dan balita di masyarakat	Monitoring Dan Evaluasi
6	Melakukan monitoring server tegalkota, bridging BPJS dan Satusehat secara berkala	Monitoring Dan Evaluasi

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci secara kontinyu dan periodik untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan berkelanjutan dilakukan oleh masing-masing OPD pemilik risiko membangun dan melaksanakan.

Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian. Beberapa hal yang harus disiapkan dalam proses ini adalah :

a. Bentuk pengendalian yang direncanakan;
a. Bentuk/metode pemantauan yang diperlukan;
b. Penanggungjawab pemantauan;
c. Prosedur pemantauan;

d. Waktu pelaksanaan.

2. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap OPD melaksanakan tindak lanjutnya.

3. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap OPD memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Inspektur Kota Tegal selaku koordinator penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kota Tegal.

BAB V
PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Kesehatan Kota Tegal Tahun 2027 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran.

Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

Tegal, Oktober 2026

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Tegal

M. ZAENAL ABIDIN, SKM, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680514 198801 1 001

KERTAS KERJA
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL
TAHUN 2027

Nama Pemda	:	PEMERINTAH KOTA TEGAL
Tahun Penilaian	:	2027
Periode yang dinilai	:	Periode Renstra Tahun 2026-2029
Urusan Pemerintahan	:	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
OPD yang Dinilai	:	DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL

PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2026

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL

Tahun Penilaian : 2027

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)			
		TIDAK SETUJU	KURANG SETUJU	SETUJU	SANGAT SETUJU
		1	2	3	4
a	b	c			
A.	**PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA**				
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)				
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai				
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik				
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku				
B	**KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI**				
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan				
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan				
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai				
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.				
C	**KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF**				
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko				
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan				
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah				
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja				
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda				
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD (*cascading*)				
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko				
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko				
D	**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN**				
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat				
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko				
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat *adhoc* (sementara)				
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko				
E	**PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT**				
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat				
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat				
3	Kewenangan direviu secara periodik				

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)			
		TIDAK SETUJU	KURANG SETUJU	SETUJU	SANGAT SETUJU
		1	2	3	4
F	**PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA**				
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)				
2	Rekruitmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik				
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja				
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko				
5	Adanya pemberian *reward* dan/atau *punishment* atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)				
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan				
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM				
G	**PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF**				
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik				
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya				
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP				
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.				
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti				

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)			
		TIDAK SETUJU	KURANG SETUJU	SETUJU	SANGAT SETUJU
		1	2	3	4
H	**HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT**				
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun				
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun				

Keterangan:
Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan

Misal:
kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL

Tahun Penilaian : 2027

NO.	RESPONDEN	PERTANYAAN /KUESIONER																																				
		A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	H1	H2
1	R1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	R2	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
3	R3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	R4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	R5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	R6	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	R7	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	R8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	R9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10	R10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	R11	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3
12	R12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	R13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14	R14	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15	R15	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16	R16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	R17	3	3	3	2	3	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	2	2	2	3	2	3	3	3	2	2	3	3
18	R18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
19	R19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
20	R20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
21	R21	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4
22	R22	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
23	R23	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	R24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
25	R25	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
26	R26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
27	R27	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
28	R28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
29	R29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
30	R30	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
31	R31	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
32	R32	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
33	R33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
34	R34	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
35	R35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
36	R36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
37	R37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
38	R38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

NO.	RESPONDEN	PERTANYAAN /KUESIONER																																				
		A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	H1	H2
39	R39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
40	R40	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4
41	R41	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
42	R42	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
43	R43	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
44	R44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
45	R45	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
46	R46	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3
47	R47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
48	R48	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4
49	R49	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
50	R50	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4
51	R51	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
52	R52	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	2	3	2	2	4	3	4	2	3	2	2	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3
53	R53	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4
54	R54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
55	R55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
56	R56	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
57	R57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
58	R58	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
59	R59	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4
60	R60	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
61	R61	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
62	R62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
63	R63	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
64	R64	4	3	4	3	3	3	3	2	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	3
65	R65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
66	R66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
67	R67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
68	R68	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
69	R69	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
70	R70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
71	R71	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
72	R72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
73	R73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
74	R74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
75	R75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
76	R76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
77	R77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
78	R78	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
79	R79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
80	R80	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
81	R81	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
82	R82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
83	R83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

NO.	RESPONDEN	PERTANYAAN /KUESIONER																																				
		A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	H1	H2
84	R84	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
85	R85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
86	R86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
87	R87	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
88	R88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
89	R89	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
90	R90	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
91	R91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
92	R92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
93	R93	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
94	R94	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3	3	3	2	1	3	2	2	2	4	4	4	4	4	3	3
95	R95	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
96	R96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
97	R97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
98	R98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
99	R99	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
100	R100	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
101	R101	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
102	R102	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
103	R103	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
104	R104	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
105	R105	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
106	R106	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
107	R107	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
108	R108	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
109	R109	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
110	R110	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
111	R111	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
112	R112	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
113	R113	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
114	R114	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
115	R115	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
116	R116	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
117	R117	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
118	R118	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
119	R119	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
120	R120	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
121	R121	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
122	R122	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4
123	R123	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
124	R124	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3
125	R125	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
126	R126	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
127	R127	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
128	R128	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3

NO.	RESPONDEN	PERTANYAAN /KUESIONER																																				
		A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	H1	H2
129	R129	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
130	R130	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
131	R131	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
132	R132	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
133	R133	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
134	R134	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
135	R135	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3
136	R136	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
137	R137	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
138	R138	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
139	R139	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
140	R140	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
141	R141	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
142	R142	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4
143	R143	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	2	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4
144	R144	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
145	R145	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
146	R146	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
147	R147	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
148	R148	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
149	R149	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
150	R150	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
151	R151	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
152	R152	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3
153	R153	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
154	R154	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3
155	R155	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
156	R156	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
157	R157	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
158	R158	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
159	R159	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
160	R160	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
161	R161	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
162	R162	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
163	R163	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
164	R164	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
165	R165	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
166	R166	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
167	R167	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
168	R168	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
169	R169	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4
170	R170	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
171	R171	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
172	R172	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
173	R173	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

NO.	RESPONDEN	PERTANYAAN /KUESIONER																																				
		A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	H1	H2
174	R174	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
175	R175	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
176	R176	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
177	R177	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
178	R178	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
179	R179	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
180	R180	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
181	R181	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
182	R182	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
183	R183	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
184	R184	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
185	R185	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
186	R186	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
187	R187	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
188	R188	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
189	R189	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
190	R190	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
191	R191	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4
192	R192	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
193	R193	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
194	R194	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
195	R195	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
196	R196	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
197	R197	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
198	R198	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
199	R199	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
200	R200	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
201	R201	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
202	R202	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
203	R203	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
204	R204	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
205	R205	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4
206	R206	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
207	R207	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
208	R208	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
209	R209	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
210	R210	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4
211	R211	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
212	R212	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
213	R213	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
214	R214	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
215	R215	4	4	4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
216	R216	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
217	R217	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
218	R218	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

NO.	RESPONDEN	PERTANYAAN /KUESIONER																																				
		A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	H1	H2
219	R219	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
220	R220	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
221	R221	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
222	R222	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
223	R223	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
224	R224	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
225	R225	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
226	R226	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
227	R227	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
228	R228	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4
229	R229	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
230	R230	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
231	R231	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
232	R232	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
233	R233	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
234	R234	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
235	R235	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4
236	R236	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
237	R237	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
238	R238	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
239	R239	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
240	R240	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
241	R241	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
242	R242	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
243	R243	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
244	R244	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
245	R245	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	4	4	4	4
246	R246	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
247	R247	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
248	R248	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
249	R249	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
250	R250	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
251	R251	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
252	R252	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
253	R253	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4
254	R254	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
255	R255	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4		3	3	3	3	3
256	R256	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3
257	R257	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
258	R258	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
259	R259	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
260	R260	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
261	R261	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
262	R262	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
263	R263	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

NO.	RESPONDEN	PERTANYAAN /KUESIONER																																				
		A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	H1	H2
264	R264	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
265	R265	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	1	1
266	R266	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
267	R267	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
268	R268	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
269	R269	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
270	R270	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
271	R271	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
272	R272	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
273	R273	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
274	R274	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
275	R275	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
276	R276	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
277	R277	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
278	R278	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
279	R279	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
280	R280	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
281	R281	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
282	R282	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
283	R283	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
284	R284	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
285	R285	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
286	R286	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4
287	R287	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
288	R288	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
289	R289	3	3	4	4	3	3	3	2	2	3	3	3	4	4	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	4
290	R290	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3
291	R291	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	2	3	3	3	2	2	2	3	2	2	3	3	3
292	R292	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
293	R293	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
294	R294	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
295	R295	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
296	R296	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
297	R297	3	3	4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4
298	R298	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3
299	R299	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
300	R300	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
301	R301	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
302	R302	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
303	R303	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
304	R304	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
305	R305	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
306	R306	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
307	R307	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
308	R308	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

NO.	RESPONDEN	PERTANYAAN /KUESIONER																																				
		A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	H1	H2
309	R309	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
310	R310	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
311	R311	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
312	R312	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3
313	R313	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
314	R314	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
315	R315	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
316	R316	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
317	R317	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
318	R318	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
319	R319	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
320	R320	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
321	R321	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
322	R322	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
323	R323	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
324	R324	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
325	R325	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
326	R326	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4
327	R327	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
328	R328	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
329	R329	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
330	R330	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
331	R331	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
332	R332	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
333	R333	3	3	3	3	2	1	3	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
334	R334	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
335	R335	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
336	R336	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
337	R337	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4
338	R338	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
339	R339	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
340	R340	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
341	R341	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
342	R342	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
343	R343	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
344	R344	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
345	R345	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
346	R346	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
347	R347	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
348	R348	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
349	R349	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
350	R350	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
351	R351	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
352	R352	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
353	R353	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

NO.	RESPONDEN	PERTANYAAN /KUESIONER																																				
		A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	H1	H2
354	R354	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
355	R355	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
356	R356	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
357	R357	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
358	R358	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	2	2	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4
359	R359	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
360	R360	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
361	R361	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
362	R362	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
363	R363	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
364	R364	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
365	R365	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
366	R366	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
367	R367	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
368	R368	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
369	R369	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
370	R370	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
371	R371	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
372	R372	2	4	4	4	2	2	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4
373	R373	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
374	R374	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
375	R375	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
376	R376	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4
377	R377	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
378	R378	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
379	R379	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
380	R380	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
381	R381	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3
382	R382	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
383	R383	4	4	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
384	R384	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
385	R385	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
386	R386	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
387	R387	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4
388	R388	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
389	R389	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
390	R390	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
391	R391	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
392	R392	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
393	R393	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
394	R394	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
395	R395	3	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
396	R396	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3
397	R397	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
398	R398	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

NO.	RESPONDEN	PERTANYAAN /KUESIONER																																				
		A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	H1	H2
399	R399	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
400	R400	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
401	R401	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
402	R402	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
403	R403	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
404	R404	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
405	R405	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
406	R406	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
407	R407	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
408	R408	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
409	R409	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
410	R410	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
411	R411	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
412	R412	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
413	R413	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
414	R414	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
415	R415	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	3	4	2	3	3	3	3	3	4	4
416	R416	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
417	R417	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
418	R418	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
419	R419	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
420	R420	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
421	R421	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
422	R422	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
423	R423	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
424	R424	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3
425	R425	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
426	R426	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
427	R427	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
428	R428	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
429	R429	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
430	R430	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
431	R431	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
432	R432	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
433	R433	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
434	R434	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
435	R435	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
436	R436	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4
437	R437	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
438	R438	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
439	R439	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
440	R440	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
441	R441	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
442	R442	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4
443	R443	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4

NO.	RESPONDEN	PERTANYAAN /KUESIONER																																			
		A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	H1	H2
444	R444	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3
445	R445	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4
446	R446	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4
447	R447	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3
448	R448	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
449	R449	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
450	R450	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
451	R451	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
452	R452	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
453	R453	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
454	R454	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
455	R455	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
456	R456	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
457	R457	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	2	4	3	4	3	4	4	3
458	R458	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
459	R459	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
460	R460	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3
461	R461	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
462	R462	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2
463	R463	3	4	4	3	3	3	4	4	2	2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4
464	R464	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
465	R465	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
466	R466	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
467	R467	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
468	R468	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
469	R469	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	4	4
470	R470	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
471	R471	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
472	R472	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
473	R473	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
474	R474	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4
475	R475	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
476	R476	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	SIMPULAN	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*
		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	SUB-UNSUR	***Memadai***				***Memadai***				***Memadai***								***Memadai***				***Memadai***			***Memadai***							***Memadai***					***Memadai***	

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban

Ket Jawaban:

1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun

2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten

3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan

4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

NO.	RESPONDEN	PERTANYAAN /KUESIONER																																		
		A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	H1	H2

Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan :

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

R1, R2, R3, R4, R5, R6: Responden

- Perwakilan Masing-masing OPD (Eselon I dan II) untuk penilaian risiko strategis pemda

A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA

A1 - Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)

A2 - Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai

A3 - Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik

A4 - Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjutisesuai ketentuan yang berlaku

B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI

B1 - Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan

B2 - Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan

B3 - Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai

B4 - Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.

C KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF

C1 - Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko

C2 - Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan

C3 - Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah

C4 - Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja

C5 - Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda

C6 - Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD (cascading)

C7 - Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko

C8 - Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat danpegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko

D PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

D1 - Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat

D2 - Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko

D3 - Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)

D4 - Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko

E PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT

E1 - Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat

E2 - Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat

E3 - Kewenangan direviu secara periodik

F PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

F1 - Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampaidengan pemberhentian pegawai)

F2 - Rekruitmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik

F3 - Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja

F4 - Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko

F5 - Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)

F6 - Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan

F7 - Instansi telah mengalokasikan anggaran yangmemadai untuk pengembangan SDM

G PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF

G1 - Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik

G2 - Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya

G3 - Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP

G4 - APIP telah melaksanakan pengawasan berbasisrisiko.

G5 - Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti

H HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT

H1 - Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun

H2 - Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun

Lampiran 5
Form 1.b

CEE BERDASARKAN DOKUMEN
KONDISI KERENTANAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
DI PEMERINTAH DAERAH KOTA TEGAL

Nama Pemda : PEMERINTAH KOTA TEGAL
Tahun Penilaian : 2027

No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
2	LHE No. 700.1.2.7/774 tanggal 21 Agustus 2026 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Paa Dinas Kesehatan Kota Tegal Tahun 2026	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah belum memuat seluruh sasaran yang tercantum pada Renstra Perangkat Daerah	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
		Struktur Pohon Kinerja (POKIN) belum sepenuhnya selaras secara hierarkis antara tujuan, sasaran, indikator, dan output kegiatan. Hubungan logis jika–maka antar level kinerja belum tersusun secara runtut, sehingga masih terdapat lompatan logika yang tidak menunjukkan keterkaitan sebab–akibat yang jelas	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
		Identifikasi crosscutting kinerja lintas sektor belum terpetakan dengan baik sehingga pola kolaborasi dengan stakeholder apa saja yang terlibat dalam mendukung kinerja lintas sektor belum terlihat dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
		Target indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah yang terdapat pada laporan kinerja triwulanan (Emonev) masih di bawah realisasi tahun sebelumnya dan tidak sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2026, serta belum terdapat link bukti dukung pada laporan kinerja triwulanan (e-Monev Kota Tegal)	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
		Perangkat Daerah belum menyajikan faktor pendorong, penghambat, dan penyesuaian strategi (tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya) pada laporan kinerja perangkat daerah triwulanan (e-Monev Kota Tegal)	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan sumber data
Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau
Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

Lampiran 5
Form 1.c

SIMPULAN SURVEI PERSEPSI ATAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DAERAH KOTA TEGAL

Nama Pemda : PEMERINTAH KOTA TEGAL
Tahun Penilaian : 2027

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai		Memadai		Memadai	
2	Komitmen terhadap kompetensi	Memadai		Memadai		Memadai	
3	Kepemimpinan yang kondusif						
4	Pembentukan Struktur organisasi sesuai kebutuhan	Memadai		Memadai		Memadai	
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Tidak Memadai	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah belum memuat seluruh sasaran yang tercantum pada Renstra Perangkat Daerah	Memadai		Tidak Memadai	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah belum memuat seluruh sasaran yang tercantum pada Renstra Perangkat Daerah
			Struktur Pohon Kinerja (POKIN) belum sepenuhnya selaras secara hierarkis antara tujuan, sasaran, indikator, dan output kegiatan. Hubungan logis jika–maka antar level kinerja belum tersusun secara runtut, sehingga masih terdapat lompatan logika yang tidak menunjukkan keterkaitan sebab–akibat yang jelas				Struktur Pohon Kinerja (POKIN) belum sepenuhnya selaras secara hierarkis antara tujuan, sasaran, indikator, dan output kegiatan. Hubungan logis jika–maka antar level kinerja belum tersusun secara runtut, sehingga masih terdapat lompatan logika yang tidak menunjukkan keterkaitan sebab–akibat yang jelas
			Identifikasi crosscutting kinerja lintas sektor belum terpetakan dengan baik sehingga pola kolaborasi dengan stakeholder apa saja yang terlibat dalam mendukung kinerja lintas sektor belum terlihat dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis				Identifikasi crosscutting kinerja lintas sektor belum terpetakan dengan baik sehingga pola kolaborasi dengan stakeholder apa saja yang terlibat dalam mendukung kinerja lintas sektor belum terlihat dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis
			Target indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah yang terdapat pada laporan kinerja triwulanan (Emonev) masih di bawah realisasi tahun sebelumnya dan tidak sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2026, serta belum terdapat link bukti dukung pada laporan kinerja triwulanan (e-Monev Kota Tegal)				Target indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah yang terdapat pada laporan kinerja triwulanan (Emonev) masih di bawah realisasi tahun sebelumnya dan tidak sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2026, serta belum terdapat link bukti dukung pada laporan kinerja triwulanan (e-Monev Kota Tegal)

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
			Perangkat Daerah belum menyajikan faktor pendorong, penghambat, dan penyesuaian strategi (tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya) pada laporan kinerja perangkat daerah triwulanan (e-Monev Kota Tegal)				Perangkat Daerah belum menyajikan faktor pendorong, penghambat, dan penyesuaian strategi (tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya) pada laporan kinerja perangkat daerah triwulanan (e-Monev Kota Tegal)
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai		Memadai		Memadai	
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Memadai		Memadai		Memadai	
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai		Memadai		Memadai	

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian
Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi
Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi
Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya
Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

Lampiran 5
Form 6

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan / RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian
(RTP atas CEE)

Nama Pemerintah Daerah : PEMERINTAH KOTA TEGAL
Tahun Penilaian : 2027

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
II	Komitmen terhadap kompetensi				
III	Kepemimpinan yang kondusif				
IV	Pembentukan Struktur organisasi sesuai kebutuhan				
V	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat				
		Menyusun Draft Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan dan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan	Sub Bagian Renvalkeu	Triwulan III 2026	Telah ditindaklanjuti
		Menginput perubahan target IKU sesuai dengan perjanjian kinerja pada sistem informasi emonev	Sub Bagian Renvalkeu	Triwulan III 2026	Belum ditindaklanjuti
		Melaksanakan Rapat koordinasi internal Dinas Kesehatan atas capaian kinerja triwulanan	Sub Bagian Renvalkeu	Triwulan III dan IV 2026 Triwul	Suah ditindaklanjuti
		Menginput faktor pendorong, faktor penghambat dan penyesuaian strategi (tindak lanjut) pada laporan kinerja triwulanan melalui aplikasi emonev	Sub Bagian Renvalkeu	Triwulan III dan IV 2026 Triwul	Sudah Ditindaklanjuti
		Mengajukan Draft usulan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan dan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan kepada Bagian Organisasi Setda Kota Tegal	Subbagian Renvalkeu	Triwulan III 2026	Belum Ditindaklanjuti
		Melaksanakan Rapat Koordinasi Internal Dinas Kesehatan untuk mengidentifikasikan CSF dan menyusun Perubahan Pohon Kinerja Dinas Kesehatan	Sub Bagian Renvalkeu	Triwulan III dan IV 2026	Telah ditindaklanjuti
		Menyusun Draft Perubahan Pohon Kinerja Dinas Kesehatan	Sub Bagian Renvalkeu	Triwulan III dan IV 2026	Sudah ditindaklanjuti
		Mengajukan Draft usulan Perubahan Perubahan Pohon Kinerja Dinas Kesehatan kepada Bagian Organisasi Setda Kota Tegal	Sub Bagian Renvalkeu	Triwulan III dan IV 2026	Belum ditindaklanjuti
		Melaksanakan Rapat Koordinasi Internal Dinas Kesehatan untuk Melakukan identifikasi potensi crosscutting kinerja yang mendukung kinerja dan penyelesaian isu strategis Dinas Kesehatan	Sub Bagian Renvalkeu	Triwulan III dan IV 2026	Sudah ditindaklanjuti
		Menyusun Draft Perubahan Crosscutting Dinas Kesehatan	Sub Bagian Renvalkeu	Triwulan III dan IV 2026	Sudah ditinklanjuti

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
		Mengajukan Draft usulan Perubahan Crosscutting Dinas Kesehatan kepada Bagian Organisasi Setda Kota Tegal	Sub Bagian Renvalkeu	Triwulan III dan IV 2026	Belum ditindaklanjuti
		Melaksanakan koordinasi dengan BAPPERIDA Kota Tegal terkait perubahan target IKU pada emonev	Sub Bagian Renvalkeu	Triwulan III 2026	Sudah ditindaklanjuti
VI	**Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM**				
VII	**Perwujudan peran APIP yang efektif**				
VIII	**Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait**				

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai
Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan
Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP
Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

Lampiran 5
Form 2a

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda Tahun Penilaian Periode yang dinilai	: PEMERINTAH KOTA TEGAL : 2027 : Periode Renstra Tahun 2026-2029
Sumber Data	: RPJMD Kota Tegal Tahun 2026-2029
Visi	: Tegal Berdikari Dan Sejahtera, Menjadi Kota Idaman
Misi Strategis RPJMD	1. Melanjutkan Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Disiplin, Kompeten Adaptif dan Inovatif
	2. Mengentaskan Kemiskinan, Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja, Masyarakat Tidak Mampu, Serta Kelompok Rentan Lainnya dengan Menciptakan Lapangan Pekerjaan, dan Membangun Ekonomi Berbasis Kemandirian dan Keadilan yang Mendorong Kemajuan Kota Tegal Sebagai Kota Bahari
	3. Meningkatkan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesehatan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Menyongsong Indonesia Emas 2045
	4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan di Segala Bidang dengan Tetap Mengutamakan Kualitas Lingkungan Hidup
	5. Membuka Akses Investasi, Pengembangan Pariwisata, Seni dan Budaya, Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Guna Pertumbuhan Ekonomi
	6. Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Menuju Keluarga Sehat, Sejahtera, Mandiri dan Berkualitas
	7. Memperkuat Moderasi Beragama dalam Kerukunan Antar Umat Beragama
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	3. Meningkatkan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesehatan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Menyongsong Indonesia Emas 2045
Tujuan Strategis RPD	Tujuan 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
	Tujuan 2. Meningkatnya Kualitas pelayanan publik
	Tujuan 3. Menurunnya angka kemiskinan
	Tujuan 4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
	Tujuan 5. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup
	Tujuan 6. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat
	Tujuan 7. Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender
	Tujuan 8. Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan
	Tujuan 9. Meningkatnya Kondusifitas Moderasi Beragama
Penetapan Konteks Tujuan	**Tujuan 4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia**
Sasaran RPJMD	Sasaran 4.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
	Sasaran 4.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Penetapan Konteks Sasaran	Sasaran 4.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
IKU Sasaran RPJMD	Indeks Pembangunan Manusia
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	**Indeks Pembangunan Manusia**
Prioritas pembangunan dan	1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
	4 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Nama Dinas Terkait	Dinas Kesehatan Kota Tegal

Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan 4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
	Sasaran 4.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
	IKU : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
	Kota Tegal, September 2026 Wali Kota Tegal DEDY YON SUPRIYONO

Lampiran 5
Form 2.b

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	:	PEMERINTAH KOTA TEGAL	
Tahun Penilaian	:	2027	
Periode yang dinilai	:	Periode Renstra Tahun 2026-2029	
Urusan Pemerintahan	:	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
OPD yang Dinilai	:	DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL	
Sumber Data	Renstra 2026-2029 Dinas Kesehatan Kota Tegal		
Tujuan Strategis	**Terwujudnya Kesehatan Untuk Semua**		
Sasaran Strategis	**Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan**		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		
IKU Renstra OPD		**IKU**	**2027**
	1	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	80,50%
	2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	79,95
Program	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
	2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		
	3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		
	4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		
	5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	**Tujuan Strategis :**		
	- Terwujudnya Kesehatan Untuk Semua		
	Sasaran Strategis:		
	- Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan		
	- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		
	IKU Strategis:		
	- Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (80,50%)		
	- Nilai AKIP Perangkat Daerah (79,95)		
	Program:		
	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
	- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		
	- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		
	- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		
	- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		
	Tegal, September 2026 Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal M. ZAENAL ABIDIN, SKM, MM NIP. 19680514 198801 1 001		

Plt. Inspektur ,

Sahudin, AK, M.Si, CA
NIP 19760726 199811 1 001

Mengetahui,
Kasubag Program, Informasi dan Humas
Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ

Muhammad Zen, A.Md
NIP 19750504 200312 1 005

Masyarakat
Kabupaten XYZ

Yeni Aprianti, SE
NIP 19790407 20021 2 2007

Lampiran 5
Form 2.c

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	:	PEMERINTAH KOTA TEGAL	
Tahun Penilaian	:	2027	
Periode yang dinilai	:	Periode Renstra Tahun 2026-2029	
Urusan Pemerintahan	:	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
OPD yang Dinilai	:	DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL	
Sumber Data	RAPBD Dinas Kesehatan Kota Tegal Tahun 2027		
Tujuan Strategis	Terwujudnya Kesehatan Untuk Semua		
Program (Renja 2027) dan Kegiatan Utama	1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
	2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
	3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
	4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
	4.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	
Keluaran/Hasil Kegiatan	1.	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
	2.	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
	3.	Persentase administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terfasilitasi	100 %
	4.	Persentase administrasi Umum perangkat daerah terfasilitasi	100 %
	5.	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
	6.	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terfasilitasi	100 %
	7.	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
	8.	Persentase fasyankes yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	100 %
	9.	Persentase Layanan Kesehatan UKM dan UKP terfasilitasi	100 %
	10.	Persentase Pustu yang menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP)	35 %
	11.	Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	100 %
	12.	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Terfasilitasi	100 %
	13.	Persentase Tenaga Kesehatan telah malaksanakan uji kompetensi	100 %
	14.	Persentase IRTP dibina dan diawasi	100 %
	15.	Persentase TPM dibina dan diawasi	100 %
	16.	Persentase Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga diperiksa	100 %
	17.	Persentase Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor terfasilitasi	100 %
	18.	Persentase Kegiatan Promkes dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat terfasilitasi	100 %
	19.	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM terfasilitasi	100 %
Keluaran/Hasil Sub Kegiatan	20	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
	21	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
	22	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	550 Orang/bulan
	23	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
	24	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
	25	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	26	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	27	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
	28	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
	29	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
	30	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
	31	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
	32	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit
	33	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
	34	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	1 Laporan
	35	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
	36	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	17 Unit
	37	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit
	38	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit
	39	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3 Unit
	40	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang	9 Unit
	41	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket
	42	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3300 Orang
	43	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2925 Orang
	44	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2925 Orang
	45	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11125 Orang

	46	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	41100 Orang
	47	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	140000 Orang
	48	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25200 Orang
	49	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400000 Orang
	50	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	4250 Orang
	51	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	690 Orang
	52	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	5500 Orang
	53	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5750 Orang
	54	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen
	55	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen
	56	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen
	57	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen
	58	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen
	59	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen
	60	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen
	61	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen
	62	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	5 Unit
	63	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan
	64	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit
	65	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	450 Orang
	66	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	34 Orang
	67	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	9 Orang
	68	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen
	69	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen
	70	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen
	71	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	1 Laporan
	72	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan	6426 Orang
	73	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1 Laporan
	74	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak	1 Laporan
	75	Jumlah FKTP yang melaksanakan pengelolaan kesehatan primer	8 Unit
	76	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	270 Orang
	77	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	11 Unit
	78	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	8 Unit
	79	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen
	80	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen
	81	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang	100 Orang
	82	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri	1 Dokumen
	83	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen
	84	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	110 Unit
	85	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan	1 Dokumen
	86	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih	1 Dokumen
	87	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber	1 Dokumen
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	***1***	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	
		Keluaran/ Hasil Kegiatan :	
		1.1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
		Keluaran/Hasil Sub Kegiatan :	
		1.1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
		1.1.2 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Keluaran/ Hasil Kegiatan :	
		1.2 Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Keluaran/Hasil Sub Kegiatan :	
		1.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		1.1.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan	
		Keluaran/ Hasil Kegiatan :	
		1.3 Persentase administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terfasilitasi	

Keluaran/Hasil Sub Kegiatan :	
1.3.1	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Keluaran/ Hasil Kegiatan :	
1.4	Persentase administrasi Umum perangkat daerah terfasilitasi
Keluaran/Hasil Sub Kegiatan :	
1.4.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
1.4.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
1.4.3	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
1.4.4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
1.4.5	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
1.4.6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
1.4.7	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Keluaran/ Hasil Kegiatan :	
1.5	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasi
Keluaran/Hasil Sub Kegiatan :	
1.5.1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Keluaran/ Hasil Kegiatan :	
1.6	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terfasilitasi
Keluaran/Hasil Sub Kegiatan :	
1.6.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.6.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
1.6.3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Keluaran/ Hasil Kegiatan :	
1.7	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terfasilitasi
Keluaran/Hasil Sub Kegiatan :	
1.7.1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
1.7.2	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
1.7.3	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
1.7.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
2	***PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT***
Keluaran/ Hasil Kegiatan :	
2.1	Persentase fasyankes yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar
Keluaran/Hasil Sub Kegiatan :	
2.1.4	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai
2.1.5	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas
2.2	- Prosentase Layanan Kesehatan UKM dan UKP terfasilitasi
Keluaran/Hasil Sub Kegiatan :	
2.2.1	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
2.2.2	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
2.2.3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
2.2.4	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
2.2.5	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
2.2.6	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
2.2.7	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
2.2.8	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
2.2.9	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
2.2.10	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai
2.2.11	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
2.2.12	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
2.2.13	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar
2.2.14	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
2.2.15	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
2.2.16	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
2.2.17	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
2.2.18	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
2.2.19	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
2.2.20	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
2.2.21	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota
2.2.22	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
2.2.23	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
2.2.24	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

2.2.25	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
2.2.26	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria
2.2.27	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
2.2.28	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi
2.2.29	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
2.2.30	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja
2.2.31	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
2.2.32	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular
2.2.33	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular
2.2.34	Jumlah FKTP yang melaksanakan pengelolaan kesehatan primer
2.2.35	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah
2.3	- Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan
Keluaran/Hasil Sub Kegiatan :	
2.3.1	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan
2.3.2	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan
3	***PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN***
Keluaran/ Hasil Kegiatan :	
3.1	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP
Keluaran/Hasil Sub Kegiatan :	
3.1.1	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3.1.2	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Keluaran/ Hasil Kegiatan :	
3.2	Persentase Tenaga Kesehatan telah malaksanakan uji kompetensi
Keluaran/Hasil Sub Kegiatan :	
3.2.1	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan
4	***PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN***
Keluaran/ Hasil Kegiatan :	
4.1	Persentase IRTP dibina dan diawasi
Keluaran/Hasil Sub Kegiatan :	
4.1.1	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat
Keluaran/ Hasil Kegiatan :	
4.2	Persentase TPM dibina dan diawasi
Keluaran/Hasil Sub Kegiatan :	
4.2.1	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan
4.3	- Persentase Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga diperiksa
Keluaran/Hasil Sub Kegiatan :	
4.3.1	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan
5	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN***
Keluaran/ Hasil Kegiatan :	
5.1	Persentase Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta masyarakat dan
Keluaran/Hasil Sub Kegiatan :	
5.1.1	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
Keluaran/ Hasil Kegiatan :	
5.2	Persentase Kegiatan Promkes dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat terfasilitasi
Keluaran/Hasil Sub Kegiatan :	
5.2.1	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
5.3	Persentase upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat terfasilitasi
Keluaran/Hasil Sub Kegiatan :	
5.3.1	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat

Tegal, Oktober 2026
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal

M. ZAENAL ABIDIN, SKM, MM
NIP. 19680514 198801 1 001

Lampiran 5
Form 3.a

KERTAS KERJA
IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Nama Pemda : Pemerintah Kota Tegal
Nama OPD : DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL
Tahun Penilaian : 2027
Periode yang dinilai : 2027
Urusan Pemerintahan

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
A	Tujuan Strategis Pemda 4 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia									
1	Sasaran 4.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Peningkatan Beban Penyakit	RSP.27.02.06.01	Kepala Daerah	Tingginya prevalensi penyakit menular (seperti TBC, HIV/AIDS, Malaria) dan penyakit tidak menular (seperti jantung, stroke, diabetes) yang tidak terkelola dengan baik	- Eksternal	UC	- Kematian bayi dan anak tinggi - kematian penduduk tinggi - Beban Biaya Kesehatan yang Tinggi	Kepala Daerah OPD Terkait Masyarakat
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Akses Pelayanan Kesehatan Terbatas	RSP.27.02.06.02	Kepala Daerah	- Penduduk miskin tidak mendaftar JKN - Penduduk miskin yang mendaftar Peserta Non PBI tidak mampu membayar premi peserta - Kepesertaan PBI APBN / APBD dinonaktifkan dari data Kemensos atau atau Pemerintah Kota Tegal	- Eksternal	UC	- Masyarakat tidak dapat mengakses layanan di fasilitas kesehatan - Angka kesakitan semakin meningkat	- Kepala Daerah '-OPD Terkait - Masyarakat

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom e diisi dengan Kode risiko
Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan Material
Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Lampiran 5
Form 3.b

KERTAS KERJA
IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	PEMERINTAH KOTA TEGAL
Nama OPD	DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL
Tahun Penilaian	2027
Periode yang dinilai	Periode Renstra Tahun 2026-2029
Tujuan Strategis	Terwujudnya Kesehatan Untuk Semua
Urusan Pemerintahan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan : Terwujudnya Kesehatan Untuk Semua	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terbatas	RSO.27.02.06.01	Kepala Dinas Kesehatan	Peserta JKN Non PBI tidak membayar premi; Pemutusan kepesertaan apabila salah satu anggota keluarga bekerja di sektor formal maupun non formal	Eksternal	UC	Masyarakat tidak mendapat layanan kesehatan baik FKTP maupun FKTL; Penambahan beban masyarakat karena harus membayar biaya layanan kesehatan	Masyarakat
	Sasaran : Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Penumpukan dan keterlambatan pelayanan pasien	RSO.27.02.06.02	Kepala Dinas Kesehatan	- Penumpukan Pasien (Overcrowding) - Waktu Tunggu yang Lama - Keterlambatan Penanganan	Eksternal	UC	- Kesulitan akses dan penolakan pasien - Peningkatan angka kesakitan dan kematian - Penurunan kualitas layanan	Wali Kota, Direktur Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, masyarakat
		Persentase RS Rujukan Tingkat kota yang terakreditasi	Penurunan Kualitas Perawatan	RSO.27.02.06.03	Kepala Dinas Kesehatan	- Rumah sakit tidak mengajukan penilaian akreditasi - Rumah sakit tidak lolos dalam penilaian akreditasi - Rumah sakit tidak memenuhi komponen dari elemen penilaian akreditasi	Eksternal	UC	- Menurunnya mutu pelayanan kesehatan - Risiko keselamatan pasien meningkat - Pencabutan Perizinan dan operasional - Tidak dapat kerjasama dengan penyedia asuransi	Wali Kota, Direktur Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, masyarakat
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Keterlambatan ibu hamil dalam mendapatkan pelayanan K6	RSO.27.02.06.04	Kepala Dinas Kesehatan	Mobilitas ibu hamil yang dinamis	Eksternal	UC	Kesehatan ibu hamil tidak terpantau	Masyarakat
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Meningkatknya risiko komplikasi persalinan	RSO.27.02.06.05	Kepala Dinas Kesehatan	- Persalinan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih - Fasilitas kesehatan kurang memadai	Eksternal	UC	Meningkatnya angka kematian ibu dan bayi	Masyarakat
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Ketidakakuratan data capaian pelayanan bayi baru lahir	RSO.27.02.06.06	Kepala Dinas Kesehatan	masih ada bayi baru lahir yang tidak terlaporkan datanya ke puskesmas	Eksternal	UC	pemantauan kesehatan bayi baru lahir kurang optimal	Masyarakat
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Target pemantauan pertumbuhan balita tidak tercapai	RSO.27.02.06.07	Kepala Dinas Kesehatan	masih ada balita yang tidak datang ke posyandu secara rutin	Eksternal	UC	tidak terpantaunya kesehatan balita	Masyarakat
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Target pemeriksaan kesehatan peserta didik tidak tercapai	RSO.27.02.06.08	Kepala Dinas Kesehatan	pada waktu pelayanan kesehatan/skrining siswa banyak yang tidak masuk/hadir	Eksternal	UC	anak pendidikan usia dasar tidak mendapatkan pelayanan secara optimal	Masyarakat
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Target pemeriksaan kesehatan usia 15-59 tahun rendah	RSO.27.02.06.09	Kepala Dinas Kesehatan	Kurang sadarnya masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan atau deteksi dini	Eksternal	UC	deteksi dini penyakit pada usia produktif tidak berjalan secara optimal	Masyarakat
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Target pemeriksaan kesehatan lansia tidak tercapai	RSO.27.02.06.10	Kepala Dinas Kesehatan	Keterbatasan lansia untuk mendatangi pelayanan kesehatan	Eksternal	UC	masyarakat tidak terakses pelayanan kesehatan	Masyarakat
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Target pemeriksaan kesehatan penderita hipertensi tidak tercapai	RSO.27.02.06.11	Kepala Dinas Kesehatan	Masih kurangnya kesadaran penderita hipertensi, tentang pentingnya pengobatan secara teratur	Eksternal	UC	deteksi dini penyakit hipertensi tidak berjalan secara optimal	Masyarakat
		Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Target pemeriksaan kesehatan penderita DM tdak tercapai	RSO.27.02.06.12	Kepala Dinas Kesehatan	Masih kurangnya kesadaran penderita DM, tentang pentingnya pengobatan secara teratur	Eksternal	UC	deteksi dini penyakit DM tidak berjalan secara optimal	Masyarakat
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Target pemeriksaan penderita ODGJ tidak tercapai	RSO.27.02.06.13	Kepala Dinas Kesehatan	Masih enggannya keluarga ODGJ untuk memeriksakan ke fasilitas kesehatan	Eksternal	UC	Penanganan ODGJ tidak berjalan secara optimal	Masyarakat
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Deteksi dini risiko TBC di masyarakat rendah	RSO.27.02.06.14	Kepala Dinas Kesehatan	Masih kurangnya kesadaran terduga TBC, tentang pentingnya pemeriksaan/ skrining TB	Eksternal	UC	deteksi dini penyakit TBC tidak berjalan secara optimal	Masyarakat
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Target skrining HIV tidak tercapai	RSO.27.02.06.15	Kepala Dinas Kesehatan	Masih kurangnya kesadaran orang berisiko HIV untuk melakukan pemeriksaan	Eksternal	UC	deteksi dini penyakit HIV tidak berjalan secara optimal	Masyarakat
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Target pemeriksaan kesehatan gratis tidak tercapai	RSO.27.02.06.16	Kepala Dinas Kesehatan	Puskesmas tidak dapat menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis	Eksternal	UC	Meningkatnya angka kesakitan di masyarakat	Masyarakat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		Jumlah Kematian Ibu	Jumlah kematian ibu melebihi target yang telah ditetapkan	RSO.27.02.06.17	Kepala Dinas Kesehatan	Ibu hamil tidak mempunyai pembiayaan untuk megakses layanan kesehatan	Eksternal	UC	Risiko kematian ibu tinggi	Masyarakat
		Jumlah kematian balita	Jumlah kematian balita melebihi target yang telah ditetapkan	RSO.27.02.06.18	Kepala Dinas Kesehatan	- Infeksi saluran pernapasan bawah, penyakit / kelainan bawaan pada bayi - Berat bayi lahir rendah - Ibu hamil KEK	Eksternal	UC	Risiko kematian balita tinggi	Masyarakat
		Prevalensi Gizi Buruk (BB/TB)	Target penurunan prevalensi gizi buruk tidak tercapai	RSO.27.02.06.19	Kepala Dinas Kesehatan	Rendahnya pola asuh orang tua, kondisi lingkungan yang buruk, sosial ekonomi keluarga rendah, penyakit kronis / bawaan pada anak	Eksternal	UC	Pertumbuhan fisik dan perkembangan mental balita terganggu	Wali Kota, Dinas Kesehatan, masyarakat
		Prevalensi Stunting	Target penurunan prevalensi stunting tidak tercapai	RSO.27.02.06.20	Kepala Dinas Kesehatan	Rendahnya pola asuh orang tua, kondisi lingkungan yang buruk, sosial ekonomi keluarga rendah, penyakit kronis / bawaan pada anak	Eksternal	UC	Pertumbuhan dan perkembangan mental balita terganggu	Wali Kota, Dinas Kesehatan, masyarakat
		Cakupan imunisasi bayi lengkap	Cakupan imunisasi bayi rendah	RSO.27.02.06.21	Kepala Dinas Kesehatan	Adanya orang tua bayi yang enggan menimunisasikan bayinya	Eksternal	UC	Meningkatnya kesakitan pada balita; Kejadian luar biasa	Dinas Kesehatan, masyarakat
		IR DBD	Kasus DBD di masyarakat tinggi	RSO.27.02.06.22	Kepala Dinas Kesehatan	Kesadaran masyarakat rendah dalam melakukan PSN, kondisi cuaca yang memungkinkan perkembangbiakan nyamuk tinggi (musim), Efektivitas Fogging Focus rendah	Eksternal	UC	- Keresahatan masyarakat akibat penularan DBD - Kematian kasus akibat DBD	Dinas Kesehatan, masyarakat
		Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Tingkat penemuan kasus TBC baru secara aktif (Case Detection Rate) rendah	RSO.27.02.06.23	Kepala Dinas Kesehatan	Fasyankes tidak melakukan skrining TBC, penggerakan masyarakat untuk pemeriksaan TBC rendah, tidak tersedia peralatan dan perlengkapan skrining TBC	Internal / Eksternal	C/UC	Peningkatan penularan kasus TBC di masyarakat	Dinas Kesehatan, masyarakat
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Penderita TBC tidak mengkonsumsi obat secara rutin	RSO.27.02.06.24	Kepala Dinas Kesehatan	Kedisiplinan pasien dalam mengkonsumsi obat rendah karena berobat lama (6 bulan); Obat tidak tersedia di fasilitas pengobatan	Internal / Eksternal	C/UC	Resistensi terhadap pengobatan TBC; Peningkatan Penularan kasus TBC Resisten Obat (RO) di masyarakat; Kematian panderita TBC	Dinas Kesehatan, masyarakat
		Prevalensi Obesitas	Meningkatnya kasus obesitas di masyarakat	RSO.27.02.06.25	Kepala Dinas Kesehatan	Masyarakat kurang beraktifitas fisik dan pola makan yang tinggi karbohidrat	Eksternal	UC	Meningkatnya risiko penyakit degeneratif	Masyarakat
		Persentase penderita depresi yang mendapatkan layanan	Rendahnya penderita depresi yang mendapatkan layanan pengobatan	RSO.27.02.06.26	Kepala Dinas Kesehatan	Kurangnya kesadaran dalam memeriksakan kondisi mental dan psikologis	Eksternal	UC	Meningkatnya risiko penyakit degeneratif	Masyarakat
		Persentase lanjut usia yang mandiri	Menurunnya jumlah orang lajut usia yang datang ke pelayanan kesehatan	RSO.27.02.06.27	Kepala Dinas Kesehatan	Kurangnya kesadaran usia lanjut untuk datang ke posyandu lansia atau fasilitas kesehatan	Eksternal	UC	Ketergantungan usia lanjut dengan keluarganya, beban keluarga dalam merawat usia lanjut	Masyarakat
		Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	Meningkatnya jumlah penduduk 10-21 tahun yang merokok	RSO.27.02.06.28	Kepala Dinas Kesehatan	Terpengaruh oleh lingkungan sebaya; Coba-coba merokok	Eksternal	UC	Meningkatnya risiko penyakit TB	Masyarakat
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rendahnya persepsi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	RSO.27.02.06.29	Kepala Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan tidak berkualitas dan bermutu	Internal	C	Kunjungan pasien rendah, turunnya target pendapatan puskesmas	Wali Kota, Dinas Kesehatan, masyarakat
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Target penduduk yang mempunyai aktifitas fisik tidak tercapai	RSO.27.02.06.30	Kepala Dinas Kesehatan	Masyarakat kurang beraktifitas fisik	Eksternal	UC	Meningkatnya risiko penyakit degeneratif	Masyarakat
		Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	Kelurahan tidak lolos dalam verifikasi STBM	RSO.27.02.06.31	Kepala Dinas Kesehatan	Kelurahan yang sudah dilakukan sosialisasi dan Pemicuan 5 pilar STBM, belum dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim	Eksternal	UC	Sulitnya Membentuk tim(Kader, Toma dan petugas)yang mampu melakukan verifikasi tingkat Kelurahan	Wali Kota, Dinas Kesehatan, masyarakat
		Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	Target Tempat Pengelolaan Pangan tidak memenuhi syarat tidak tercapai	RSO.27.02.06.32	Kepala Dinas Kesehatan	Sanitasi dan kebersihan Tempat pengolah pangan tidak higienis	Eksternal	UC	Meningkat risiko keracunan pangan terhadap produk hasil olahan	Masyarakat
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Target Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan tidak tercapai	RSO.27.02.06.33	Kepala Dinas Kesehatan	Keterbatasan sarana dan prasarana; Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)	Eksternal	UC	Pelayanan di fasilitas kesehatan kurang bermutu	Masyarakat
		Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	Target fasilitas pelayanan kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional tidak tercapai	RSO.27.02.06.34	Kepala Dinas Kesehatan	Fasilitas Kesehatan belum mempunyai sistem informasi kesehatan (SIK)	Eksternal	UC	Riwayat kesehatan pasien tidak terdokumentasi dengan baik; Risiko kesalahan diagnosis atau pengobatan	Masyarakat
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Hasil akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tidak mendapatkan strata paripurna	RSO.27.02.06.35	Kepala Dinas Kesehatan	Fasilitas Kesehatan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan	Eksternal	UC	Pelayanan di fasilitas kesehatan kurang bermutu	Masyarakat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tidak memenuhi persyaratan ASPAK	RSO.27.02.06.36	Kepala Dinas Kesehatan	Fasilitas kesehatan tidak memenuhi persyaratan perbekalan kesehatan yang telah ditetapkan	Eksternal	UC	Pelayanan di fasilitas kesehatan kurang bermutu	Masyarakat
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan sesuai standar kompetensi	Tenaga kesehatan tidak dapat mengikuti uji kompetensi	RSO.27.02.06.37	Kepala Dinas Kesehatan	Jumlah penyelenggara kegiatan peningkatan kompetensi SDMK yang sesuai dengan kebutuhan dan telah terstandardisasi terbatas	Internal / Eksternal	C/UC	Ketersediaan SDMK yang telah memiliki kompetensi sesuai belum optimal	Dinas Kesehatan
		Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Penyebaran tenaga kesehatan tidak merata	RSO.27.02.06.38	Kepala Dinas Kesehatan	Kekurangan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam melayani masyarakat	Internal / Eksternal	C/UC	Pelayanan di fasilitas kesehatan terhambat	Masyarakat
		Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	Terget puskesmas dengan SDMK sesuai standar tidak terpenuhi	RSO.27.02.06.39	Kepala Dinas Kesehatan	Jumlah tenaga yang ada belum memenuhi anjab dan ABK	Internal / Eksternal	C/UC	Pelayanan di fasilitas kesehatan kurang bermutu	Masyarakat
		Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Tidak terpenuhi jenis dan jumlah dokter spesialis di RS pemerintah	RSO.27.02.06.40	Kepala Dinas Kesehatan	RS Pemerintah tidak dapat menyediakan dokter spesialis	Internal / Eksternal	C/UC	Pelayanan di RS Pemerintah kurang	Masyarakat
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar kefarmasian	Masih ditemukan sarana kesehatan tidak memenuhi standar kefarmasian (Lemahnya penerapan sistem pengelolaan stok)	RSO.27.02.06.41	Kepala Dinas Kesehatan	Sarana kesehatan tidak mematuhi pedoman dalam praktik kefarmasian untuk memastikan kualitas dan keselamatan pasien	Internal / Eksternal	C/UC	Obat yang diberikan membahayakan keselamatan pasien	Masyarakat
		Persentase TPM yang memenuhi syarat	Tempat pengelolaan Makanan (TPM) yang tidak dapat memenuhi syarat dalam pengelolaan makanan	RSO.27.02.06.42	Kepala Dinas Kesehatan	Tempat pengelolaan Makanan (TPM) mengelola makanan tidak sesuai dengan ketentua yang berlaku	Eksternal	UC	Risiko keracunan makanan	Masyarakat
		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar	Pemenuhan komitmen oleh sarana IRTP tidak optimal (kesulitan mengakses dan mengoperasikan sistem aplikasi)	RSO.27.02.06.43	Kepala Dinas Kesehatan	Kemudahan mekanisme mendapatkan ijin PIRT dengan terbitnya SPPIRT sebelum pemeriksaan sarana IRTP	Internal	C	Kurang optimalnya pembinaan dan pengawasan sarana IRTP karena pemilik sarana IRTP tidak optimal dalam pemenuhan komitmen	Masyarakat
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	Kurangnya konsistensi penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) oleh P-IRT	RSO.27.02.06.44	Kepala Dinas Kesehatan	Industri Rumah Tangga kurang higienis baik lingkungan maupun penjamah makanan dalam mengelola pangan	Eksternal	UC	Risiko keracunan makanan	Masyarakat
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	IRTP tidak dapat memenuhi persyaratan LSHS	RSO.27.02.06.45	Kepala Dinas Kesehatan	Industri Rumah Tangga kurang higienis baik lingkungan maupun penjamah makanan dalam mengelola pangan	Eksternal	UC	Risiko keracunan makanan	Masyarakat
		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	Target apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan tidak memuhi target	RSO.27.02.06.46	Kepala Dinas Kesehatan	Masih ditemukan apotek dan toko obat yang tidak mempertahankan izin yang dipersyaratkan	Eksternal	UC	Pencabutan izin apotek dan toko obat	apotek dan toko obat
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	Hasil rekomendasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	RSO.27.02.06.47	Kepala Dinas Kesehatan	Beban tugas pemegang program yang terlalu banyak	Eksternal	UC	Risiko keracunan obat dan makanan	Masyarakat
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga sehat strata paripurna	Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat	RSO.27.02.06.48	Kepala Dinas Kesehatan	Rendahnya perilaku masyarakat dalam indikator PHBS yaitu cuci tangan dengan sabun dan air bersih, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan merokok di dalam rumah	Eksternal	UC	Penularan penyakit menular; peningkatan penyakit tidak menular; Anggota keluarga mudah sakit; Lingkungan tidak bersih, aman dan nyaman	Dinas Kesehatan, Masyarakat
	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan menurun dari tahun sebelumya	RSO.27.02.06.49	Kepala Dinas Kesehatan	Proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi kinerja tidak sesuai dengan ketentuan; Target kinerja tidak tercapai	Internal	C	Indikator kinerja tidak tercapai	Dinas Kesehatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Indeks kematangan organisasi Dinkes Kesehatan menurun dari tahun sebelumnya	RSO.27.02.06.50	Kepala Dinas Kesehatan	Banyak karyawan yang resisten terhadap perubahan	Internal	C	Indikator matangan organisasi tidak tercapai	Dinas Kesehatan

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom e diisi dengan Kode risiko

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Lampiran 5
Form 3.c

KERTAS KERJA
IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL OPD

ama Pemda	PEMERINTAH KOTA TEGAL
Nama OPD	DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL
hun Penilaian	2027
ode yang dinilai	Periode Renstra Tahun 2026-2029
uan Strategis	Terwujudnya Kesehatan Untuk Semua
an strategis OPD	Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
n Pemerintahan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										
1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										
	Risiko Fraud										
1.1.1	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Pelaksanaan	Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan tidak terpelihara dengan baik	ROO.27.02.06.01	Kepala Bidang Fasyankes	Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik tidak terpelihara dengan baik - Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik tidak dilakukan kalibrasi	Eksternal	UC	Pelayanan masyarakat terganggu, kesalahan dalam penegakkan diagnosa penyakit pasien	Dinas Kesehatan, Puskesmas,Masyarakat
1.1.2	*Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan*	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*	*Persiapan, Pelaksanaan*	*Proses pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan tidak sesuai DPA (Risiko Fraud)*	ROO.27.02.06.02	*Kepala Bidang Fasyankes*	*Gagal dalam pengadaan obat, BMHP*	*Eksternal / Internal*	*UC*	*Pelayanan kepada masyarakat terganggu karena tidak tersedia obat dan BMHP*	*Dinas Kesehatan, Puskesmas, KPM, Masyarakat*
1.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
1.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pelaksanaan	Rendahnya pengetahuan ibu hamil/keluarga tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan dan jadwalnya	ROO.27.02.06.03	Kepala Bidang UKMP	ANC Terpadu tidak berjalan dengan baik, skrining risiko kehamilan kurang optimal, kelas ibu hamil yang terbentuk masih kurang	Internal	C	- Ibu hamil tidak tahu status kesehatan diri dan kehamilannya - Meningkatnya risiko kematian ibu	Dinas Kesehatan, Masyarakat
1.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pelaksanaan	Kekurangan Kompetensi Tenaga Kesehatan	ROO.27.02.06.04	Kepala Bidang UKMP	Tenaga kesehatan (nakes) tidak memiliki pelatihan terkini atau keterampilan yang kurang dalam penanganan komplikasi persalinan	Internal	C	Ibu bersalin tidak mendapatkan rujukan yang adekut ketika terjadi permasalahan dalam persalinan	Dinas Kesehatan, Masyarakat
1.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pelaksanaan	Tidak dilakukan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) tidak terhadap anak baru lahir	ROO.27.02.06.05	Kepala Bidang UKMP	Petugas tidak melaksanakan kegiatan, sampel tidak dikirim ke Labortaorium yang sudah ditunjuk	Internal	C	Kelainan hormon tiroid tidak terdeteksi secara dini yang berakibat pada risiko timbulnya gangguan fisik dan mental dalam tumbuh kembang anak	Dinas Kesehatan, Masyarakat
1.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pelaksanaan	Rendahnya Kunjungan Balita ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan	ROO.27.02.06.06	Kepala Bidang UKMP	- Tidak dilakukan pemantauan wilayah setempat (PWS) kesehatan balita - Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran Orang Tua/Masyarakat - Kader Posyandu kurang terampil atau kurang aktif	Intarnal	C	Status gizi dan tumbuh kembang balita tidak terpantau, penanganan kasus terlambat	Dinas Kesehatan, Masyarakat
1.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pelaksanaan	Partisipasi sekolah dalam pemeriksaan berkala atau penjaringan anak sekolah rendah	ROO.27.02.06.07	Kepala Bidang UKMP	Ketidakaktifan UKS atau Kurangnya komitmen kepala sekolah/guru terhadap pelaksanaan program kesehatan	Eksternal / Internal	C	a. Siswa tidak terpantau status kesehatannya b. Siswa tidak mendapatkan pelayanan pendidikan kesehatan dari petugas kesehatan	Pemerintah, individu, keluarga & Masyarakat
1.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pelaksanaan	- Tidak dapat dilakukan skrining risiko PTM pada usia produtif - Posbindu Remaja tidak dapat dilaksanakan	ROO.27.02.06.08	Kepala Bidang UKMP	- BMHP untuk pelaksanaan skirining usia produktif tidak tersedia - Kader Posyandu Remaja tidak ada	Eksternal / Internal	C	- Risiko penyakit tidak menular di masyarakat semakin meningkat - Pertumbuhan dan perkembangan remaja tidak diketahui	Dinas Kesehatan, Masyarakat
1.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pelaksanaan	Posyandu lansia tidak dapat terlaksana	ROO.27.02.06.09	Kepala Bidang UKMP	Bahan PMT untuk kegiatan Posyandu Lansia tidak tersedia	Internal	C	Kesehatan lansia tidak dapat dipantau dengan baik	Dinas Kesehatan, Masyarakat
1.2.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pelaksanaan	Masyarakat yang berkunjung ke pelayanan kesehatan tidak dilakukan skrining faktor risiko penyakit tidak menular khususnya hipertensi	ROO.27.02.06.10	Kepala Bidang UKMP	Petugas tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan skrining faktor risiko penyakit tidak menular khususnya hipertensi	Internal	C	Masyarakat tidak mengetahui risiko penyakit menular khusunya hipertensi	Dinas Kesehatan, Masyarakat
1.2.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pelaksanaan	Masyarakat yang berkunjung ke pelayanan kesehatan tidak diperiksaan kadar gula darah	ROO.27.02.06.11	Kepala Bidang UKMP	BMHP stik glukosa tidak tersedia	Internal	C	Masyarakat tidak mengetahui risiko penyakit menular khusunya hipertensi	Dinas Kesehatan, Masyarakat
1.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Pelaksanaan	Penderita ODGJ tidak berobat dan tidak minum obat secara rutin	ROO.27.02.06.12	Kepala Bidang UKMP	a. Keluarga penderita kurang / tidak kooperatif b. Terbatasnya fasilitas kesehatan c. Diskriminasi dalam Kelg / Masy d. Terbatasnya Tenaga Kesahatan terlatih Kesehatan Jiwa	Eksternal	UC	a. Terganggunya kesejahteraan keluarga / Beban Ekonomi b. Keresahan Masyarakat c. Produktifitas Penderita menurun d. Memperberat kondisi kesehatan jiwa penderita	Pemerintah, Individu, Keluarga & Masyarakat
1.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pelaksanaan	Penemuan kasus aktif TB (Case Finding) rendah	ROO.27.02.06.13	Kepala Bidang UKMP	- Petugas tidak melakukan skrining dan pemeriksaan terhadap pasien yang berisiko tinggi kasus TB - Masyarakat/Pasien tidak datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) untuk pemeriksaan meskipun bergejala (Suspek TBC) - Adanya stigma negatif dan diskriminasi di masyarakat sehingga terduga TBC menolak diperiksa/diobati atau tidak jujur menyampaikan gejala	Internal	C	Peningkatan penularan kasus TB di masyarakat	Dinas Kesehatan, Masyarakat
1.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pelaksanaan	Tidak dapat melakukan Test HIV/AIDS	ROO.27.02.06.14	Kepala Bidang UKMP	Rapid Test pemeriksaan HIV/AIDs tidak tersedia	Internal	C	Penularan HIV/AIDS meningkat di masyarakat	Dinas Kesehatan, Masyarakat
1.2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Pelaksanaan	Penyakit potensial wabah tidak terpantau dengan baik	ROO.27.02.06.15	Kepala Bidang UKMP	Tidak dilakukan pemantauan terhadap penyakit potensial wabah	Internal	C	Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah terjadi masyarakat	Dinas Kesehatan, Masyarakat

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.2.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pelaksanaan	a. Penderita Gizi Buruk tidak mendapat Pelayanan / Perawatan yang optimal b. Bantuan PMT tidak dikonsumsi oleh penderita c. Kualitas PMT yang kurang baik d. Pemberian PMT tidak berkelanjutan atau jumlah pemberian tidak sesuai volume yang seharusnya diperoleh penderita	ROO.27.02.06.16	Kepala Bidang UKMP	Praktek pengasuhan anak yang tidak baik; Kurangnya kemampuan memperoleh makanan bergizi; Kondisi lingkungan yang kurang sehat; Tidak punya jaminan kesehatan; Kurangnya akses air bersih & sanitasi.	Eksternal	UC	a. Mudah sakit b. Kemampuan kognitif berkurang c. Fungsi-fungsi tubuh tdk seimbang d. Postur tubuh tdk maksimal saat dewasa e. Mengakibatkan kerugian ekonomi	Pemerintah, Individu, Keluarga & Masyarakat
1.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pelaksanaan	Tidak ada dokumen hasil studi penilaian risiko kesehatan lingkungan	ROO.27.02.06.17	Kepala Bidang UKMP	Pemeriksaan sampel air minum, sampel air bersih tidak dilakukan	Internal / Eksternal	UC	Kebijakan program kesehatan lingkungan tidak sesuai dengan permasalahan	Pemerintah & Masyarakat
1.2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Pelaksanaan	Tidak Terbentuknya Asman TOGA, Kegiatan Asman TOGA Berhenti, Tidak Tersedianya Lahan untuk budi daya TOGA	ROO.27.02.06.18	Kepala Bidang UKMP	SDM Kurang, Petugas yang sudah dilatih Diklat TOGA dan Akupresur tidak ada Tindak lanjut, Pengawasan dari Diklat Tidak ada	Internal	C	SDM Tidak Kompeten, Pengawasan Terhadap Kelompok Asuhan Mandiri kurang, Tidak Teregistrasi Kelompok Asman/TOGA	Pemerintah & Masyarakat
1.2.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pelaksanaan	a. Bayi dan balita tidak mendapatkan imunisasi lengkap, b. Keluarga takut anaknya sakit setelah diimunisasi c. Terbatasnya stok vaksin tertentu di tingkat pusat hingga ke daerah	ROO.27.02.06.19	Kepala Bidang UKMP	a. Keluarga menolak karena alasan agama (vaksin haram) b. Kurang pengetahuan dari keluarga tentang pentingnya imunisasi c. Belum ada regulasi untuk memindahkan stock vaksin dr Fasyankes yg berlebih ke Fasyankes yang kekurangan stock	Eksternal / Internal	UC	a. Anak yang tidak diimunisasi lebih berisiko terkena penyakit menular b. Target IDL tidak tercapai c. Dapat terjadi KLB	Pemerintah, individu, keluarga & Masyarakat
	Risiko Kemitraan										
1.2.18	*Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*	*Pelaksanaan*	*Iur Premi BPJS Kesehatan PBI APBD II terlambat*	ROO.27.02.06.20	*Kepala Bidang UKMP*	*Bakeuda terlambat membayar iur*	*Eksternal*	*UC*	*Penerima PBI APBD II tidak dapat menerima layanan kesehatan*	*Pemerintah & Masyarakat*
			Pelaksanaan	Penduduk Maskin tidak terlayani kesehatannya karena tidak ada biaya	ROO.27.02.06.21	Kepala Bidang UKMP	a. Maskin tidak aktif melapor jika kepersertaan dinon-aktifkan b. Database DTKS tidak valid c. Kebijakan penonaktifan jika ada anggota yang sudah bekerja (JKN Non PBI)	Eksternal	UC	a. Maskin tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan terutama pada FKTL b. Keresahan pada masyarakat khususnya maskin	Pemerintah & Masyarakat
1.2.19	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Pelaksanaan	Dokumen tatanan Kota Sehat tidak tersedia dengan lengkap	ROO.27.02.06.22	Kepala Bidang UKMP	Tidak dilakukan Pendampingan Kegiatan Tatanan Kota Sehat, kurangnya kapasitas forum komunikasi dan pokja kelurahan sehat	Internal	C	Hasil penilaian Kota Sehat tidak sesuai dengan target	Pemerintah
1.2.20	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pelaksanaan	Keterbatasan informasi ketersediaan ruang rawat di Fasyankes	ROO.27.02.06.23	Kepala Bidang UKMP	Tidak ada informasi ketersediaan ruang rawat dari Fasyankes	Internal	C	a. Pelayanan tidak maksimal b. Pasien terlantar c. Pelayanan terhadap masyarakat tidak memuaskan	Pemerintah & Masyarakat
1.2.19	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Monitoring dan pembinaan pasca akreditasi tidak dilakukan	ROO.27.02.06.24	Kepala Bidang UKMP	Tidak dilakukan tindak lanjut rekomendadi pasca penilaian akreditasi	Internal	C	a. Pelayanan tidak sesuai standar b. Administrasi tidak tertib c. Pelayanan pada masyarakat tidak memuaskan	Pemerintah & Masyarakat
1.2.20	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Pelaksanaan	Tidak dketahui penyebab kasus kejadian KIPI berdasarkan kajian medis	ROO.27.02.06.25	Kepala Bidang UKMP	Tidak terselenggaranya pertemuan kajian kasus KIPI	Internal	C	Persepsi masyarakat terhadap program imunisasi semakin berkurang	Pemerintah & Masyarakat
1.2.21	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Pelaksanaan	Kapasitas dan kemampuan petugas dalam pelayanan SPGDT kurang memadai	ROO.27.02.06.26	Kepala Bidang UKMP	Kapasitas dan kemampuan petugas dalam pelayanan SPGDT kurang memadai	Internal	C	Pelayanan SPGDT tidak sesuai berkurang	Pemerintah & Masyarakat
1.2.22	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Perencanaan	Penderita TB tidak memperoleh PMT untuk perbaikan gizi	ROO.27.02.06.27	Kepala Bidang UKMP	Tidak tersedianya pengadaan PMT TB SO & Ekstra Paru	Internal	C	Kondisi status gizi penderita TB semakin buruk yang akan memperparah kondisi kesehatannya	Pemerintah & Masyarakat
1.2.23	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Perencanaan	Penderita HIV / AIDS tidak mendapatkan dukungan dan motivasi dari sesama penderita HIV / AIDS	ROO.27.02.06.28	Kepala Bidang UKMP	Tidak ada pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya HIV / AIDS	Internal	C	Risiko penularan HIV/AIDS di masyarakat	Pemerintah & Masyarakat
1.2.24	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Perencanaan	Kasus malaria di rumah sakit tidak dilaporkan	ROO.27.02.06.29	Kepala Bidang UKMP	Petugas Rumah Sakit tidak melaporkan apabila ada pasien dengan kasus malaria di rumah sakit	Internal	C	Risiko penularan malaria di masyarakat	Pemerintah & Masyarakat
1.2.25	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Perencanaan	Masih tingginya ibu hamil risiko tinggi	ROO.27.02.06.30	Kepala Bidang UKMP	Ibu dan anak enggan untuk mengakses layanan kesehatan yang disediakan	*Eksternal*	*UC*	Ibu dan anak tidak dapat mengakses layanan kesehatan	Pemerintah & Masyarakat
1.2.26	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pelaksanaan	Bayi dan balita tidak mendapatkan imunisasi lengkap	ROO.27.02.06.31	Kepala Bidang UKMP	1. masih terdapat penolakan imunisasi di masyarakat karena berbagai sebab, antara lain isu hoax, kurangnya pengetahuan masyarakat ttg imunisasi, kepercayaan antivaks, dll 2. sistem pendataan sasaran imunisasi kurang kuat (terdapat Puskesmas yg blm mempunyai data sasaran imunisasi yg ada di wilayahnya) 3. terdapat gap cakupan imunisasi secara manual dan secara aplikasi ASIK antara lain disebabkan sistem pencatatan dan pelaporan hasil imunisasi di ASIK tdk real time, aplikasi ASIK sering maintenance, dan tdk lengkapnya data yang akan diinput ke dalam aplikasi	Eksternal / Internal	UC	a. Anak yang tidak diimunisasi lebih berisiko terkena penyakit menular b. Target IDL tidak tercapai c. Dapat terjadi KLB	Pemerintah, individu, keluarga & Masyarakat
1.2.27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Pelaksanaan	Tidak terselenggaranya pemeriksaan kesehatan haji bagi calon jamaah haji	ROO.27.02.06.32	Kepala Bidang UKMP	Puskesmas tidak melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan calon jamaah haji	Internal	C	Calon jamaah haji tidak bisa berangkat ke tanah suci	Pemerintah & Masyarakat
1.2.28	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	Pelaksanaan	Perusahaan / pekerja tidak berpartisipasi dalam K3	ROO.27.02.06.33	Kepala Bidang UKMP	a. Kurang sosialisasi b. Perusahaan krg / tdk kooperatif c. Belum optimalnya jejaring kerja d. Rendahnya pengetahuan / kesadaran pekerja terhadap kesja	Internal / Eksternal	UC	a. Pekerja sakit b. Produktifitas menurun c. Penularan penyakit ditempat kerja d. Serapan anggaran tidak optimal e. Meningkatnya penyakit akibat kerja / kecelakaan kerja f. Kesejahteraan pekerja menurun	Perusahaan & Masyarakat

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.2.29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Pelaksanaan	Penderita ODGJ tidak berobat - Penderita ODGJ tidak minum obat secara rutin	ROO.27.02.06.34	Kepala Bidang UKMP	a. Keluarga penderita kurang / tidak kooperatif b. Terbatasnya fasilitas kesehatan c. Diskriminasi dalam Kelg / Masy d. Terbatasnya Tenaga Kesahatan terlatih Kesehatan Jiwa	Eksternal	UC	a. Terganggunya kesejahteraan keluarga / Beban Ekonomi b. Keresahan Masyarakat c. Produktifitas Penderita menurun d. Memperberat kondisi kesehatan jiwa penderita	Pemerintah, Individu, Keluarga & Masyarakat
1.2.30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Pelaksanaan	Terjadinya penularan penyakit	ROO.27.02.06.35	Kepala Bidang UKMP	Tidak ada pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Eksternal	UC	Angka kesakitan di masyarakat tinggi	Pemerintah, Individu, Keluarga & Masyarakat
1.2.31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Pelaksanaan	- Tidak dapat dilakukan skrining risiko PTM pada usia produtif - Posbindu Remaja tidak dapat dilaksanakan	ROO.27.02.06.36	Kepala Bidang UKMP	- BMHP untuk pelaksanaan skirining usia produktif tidak tersedia - Kader Posyandu Remaja tidak ada	Eksternal / Internal	C	- Risiko penyakit tidak menular di masyarakat semakin meningkat - Pertumbuhan dan perkembangan remaja tidak diketahui	Dinas Kesehatan, Masyarakat
1.2.32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah FKTP yang melaksanakan pengelolaan kesehatan primer	Pelaksanaan	Terjadinya insiden keselamatan pasien, seperti salah diagnosis, kesalahan pemberian obat (medication error), atau komplikasi penanganan medis akibat ketidakpatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP)	ROO.27.02.06.37	Kepala Bidang UKMP	- Kompetensi tenaga kesehatan yang belum merata atau kurangnya pelatihan berkala. - Beban kerja yang tinggi (rasio pasien dan tenaga medis yang tidak seimbang) sehingga terjadi kelelahan (burnout). - SOP yang tidak tersedia, kedaluwarsa, atau tidak dipahami dengan baik oleh staf.	Eksternal / Internal	C	Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan primer.	Dinas Kesehatan, Masyarakat
1.2.33	Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Pelaksanaan	Tidak dilakukan skrining NAPZA untuk masyarakat dan anak sekolah	ROO.27.02.06.38	Kepala Bidang UKMP	Test Urine NAPZA tidak tersedia	Internal	C	Meluasnya penyebaran penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan anak sekolah	Pemerintah & Masyarakat
1.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi										
	Risiko SPBE										
1.3.1	*Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	*Pelaksanaan*	*SIMPUS tidak dapat diakses*	ROO.27.02.06.39	*Kepala Bidang Fsyankes*	*Server SIMPUS down*	*Eksternal*	*UC*	*Pasien tidak mendapat layanan kesehatan dengan cepat dan akurat*	*Masyarakat*
1.4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
1.4.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Pelaksanaan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak teregistrasi perizinannya di Kementerian Kesehatan	ROO.27.02.06.40	Kepala Bidang UKMP	Tidak dilakukan sosialisasi dan fasilitasi registrasi fasilitas pelayanan kesehatan kesehatan	Internal	C	Fasyankes tidak dapat beroperasi	Pemerintah & Masyarakat
1.4.2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Pelaksanaan	Fasilitas pelayanan Kesehatan tidak menigrimkan laporan indikator mutu ke Kemkes	ROO.27.02.06.41	Kepala Bidang UKMP	Tidak dilakukan monitoring dan bimtek peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan kesehatan	Internal	C	Penurunan mutu layanan di Fasyankes	Pemerintah & Fasyankes
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										
2.1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota										
2.1.1	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pelaksanaan	Puskesmas, Pustu dan Posyandu ILP tidak berjalan	ROO.27.02.06.42	Kepala Bidang SDMK	Tidak dilakukan pendampingan dan bimbingan teknis kepada puskesmas untuk melakukan program ILP	Internal	C	Teguran dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kemkes	Dinas Kesehatan
2.1.2	Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pelaksanaan	Puskesmas, Pustu dan Posyandu ILP tidak berjalan	ROO.27.02.06.43	Kepala Bidang SDMK	Tidak dilakukan pendampingan dan bimbingan teknis kepada puskesmas untuk melakukan program ILP	Internal	C	Teguran dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kemkes	Dinas Kesehatan
2.2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
2.2.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Pelaksanaan	Tenaga Kesehatan tidak dapat mengikuti Uji Kompetensi	ROO.27.02.06.44	Kepala Bidang SDMK	Pembinaan dan Uji Kompetensi tidak dapat terlaksana	Internal	C	Pelayanan kesehatan ke masyarakat tidak sesuai dengan kompetensi	Pemerintah & Masyarakat
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN										
3.1	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga										
3.1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pelaksanaan	Pangan yang beredar tidak memiliki Ijin edar (SPPIRT)	ROO.27.02.06.45	Kepala Bidang Fasyankes	a. Ketidaktahuan produsen tentang ijin edar b. Stigma di masyarakat jika mengurus ijin sulit	Eksternal	UC	a. Pangan yang beredar tidak memiliki ijin edar. b. Beredarnya pangan yang tidak aman di masyarakat	Masyarakat, pelaku usaha
3.2	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)										
3.2.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pelaksanaan	TPM tidak memiliki ijin Laik Hygiene Sanitasi	ROO.27.02.06.46	Kepala Bidang Fasyankes	Ketidaktahuan pelaku usaha cara perijinan laik Hygiene Sanitasi	Eksternal	UC	a. Beredarnya pangan yang tidak aman dan sehat b. Timbulnya penyakit yang disebabkan oleh makanan (*Food Disease*)	Masyarakat, pelaku usaha
3.3	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga										
3.3.1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Pelaksanaan	Pangan yang beredar tidak tidak aman dan tidak sehat	ROO.27.02.06.47	Kepala Bidang Fasyankes	a. Ketidaktahuan produsen tentang pangan yang aman dan sehat b. Faktor Profit	Internal	C	a. Beredarnya pangan yang tidak aman dan sehat b. Timbulnya penyakit yang disebabkan oleh makanan (*Food Disease*)	Masyarakat, pelaku usaha

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
4	PPROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										
4.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
4.1.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksanaan	Tidak optimalnya pokjanal Posyandu dan Forum Kesehatan Kelurahan	ROO.27.02.06.48	Kepala Bidang SDMK	Tidak terselenggarakan bintek dan pendampingan unrtuk Pokjanal Posyandu dan Kesi	Internal	C	Posyandu dan Kelurahan siaga tidak berjalan optimal	Dinas Kesehatan, Kelurahan dan masyarakat
4.2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
4.2.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Pelaksanaan	a. Tidak tersedianya data PHBS rumah tangga yang akurat. b. Tidak terselenggaranya kegiatan promosi kesehatan (media cetak, penyuluhan langsung, siaran radio) kepada masyarakat c. Terkendalanya gerakan masyarakat hidup sehat	ROO.27.02.06.49	Kepala Bidang SDMK	a. Keterbatasan penguasaan dan keterampilan kader dalam pelaksanaan pendataan PHBS b. Anggaran terbatas c. Kemampuan petugas dalam teknologi informasi masih rendah	Internal	C	a. Akurasi data PHBS rendah b. Pengetahuan masyarakat tentang kesehatan rendah c. Derajat kesehatan masyarakat tidak optimal	Pemerintah & Masyarakat
4.3	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
4.3.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pelaksanaan	a. Tidak tersedianya data PHBS Tatanan Rumah Tangga b. Tidak optimalnya pokjanal Posyandu dan Forum Kesehatan Kelurahan 'c. Tidak berjalannya kegiatan upaya kesehatan berbasis masayarakat /UKBM (Posyandu, Posbindu, Poslansia dll) d. Tidak terlaksananya lomba kader Posyandu bidang kesehatan	ROO.27.02.06.50	Kepala Bidang SDMK	"a. Keterbatasan penguasaan dan keterampilan kader dalam pelaksanaan pendataan PHBS b. Anggaran untuk pendataan PHBS tatanan RT terbatas c. Kemampuan petugas dalam teknologi informasi masih rendah d. Tidak terselenggarakan bintek dan pendampingan unrtuk Pokjanal Posyandu dan Kesi e. Keterlambatan terbitnya SK Kader Kesehatan f. Keterlambatan pengajuan keuangan g. Keterlambatan Pembayaran keuangan h. Keterlambatan dalan penandatangan penerimaan uang oleh kader i. Tidak tersedia dana untuk kegiatan lomba kader Posyandu bidang kesehatan"	Internal	C	"a. Akurasi data PHBS rendah b. Pengetahuan masyarakat tentang kesehatan rendah c. Derajat kesehatan masyarakat tidak optimal d. Posyandu dan Kelurahan siaga tidak berjalan optimal e. Kinerja kader tidak optimal f. Bayi, balita, usia produktif, lansia tidak mendapatkan pelayanan kesehatan di Posyandu/Posbindu/Poslanis dll g. Kegiatan pendataan program kesehatan yang dilakukan oleh kader tidak terlaksana h. Menurunannya derajat kesehatan masyarakat" i. Menurunnya semangat kinerja kader dalam bertugas	Pemerintah & Masyarakat
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
5.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terlambat disusun	ROO.27.02.06.51	Kasubg Renvalkeu	Kurangnya komunikasi internal terkait rencana kegiatan perangkat daerah	Internal	C	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan	Dinas Kesehatan
5.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlambat disusun	ROO.27.02.06.52	Kasubg Renvalkeu	Kurangnya bahan penyusunan laporan kinerja atau data capaian kinerja tidak lengkap	Internal	C	Nilai AKIP OPD turun	Dinas Kesehatan
5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pelaksanaan	Dokumen gaji pegawai tidak sesuai	ROO.27.02.06.53	Kasubg Renvalkeu	Bendahara gaji tidak cermat dalam membuat dokumen gaji pegawai	Internal	C	Gaji yang diterima tidak sesuai	Dinas Kesehatan
5.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan	Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran (SPJ) tidak terverifikasi lengkap	ROO.27.02.06.54	Tim Penatausahaan Keuangan	Staf administrasi tidak lengkap dalam melengkapi 'Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran (SPJ) kegiatan	Internal	C	Ajuan Ganti Uang (GU) terlambat cair	Dinas Kesehatan
5.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
5.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelaksanaan	Laporan BMD belum sesuai kondisi yang ada	ROO.27.02.06.55	*Kasubag Umpeg*	Ketelitian pengurus barang dalam pengelolaan aset barang milik daerah masih kurang	Internal	C	Laporan keuangan dan BMD tidak sesuai	Dinas Kesehatan
5.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
	Risiko Fraud										
5.4.1	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*Pelaksanaan*	*Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak sesuai DPA (Risiko Fraud)*	ROO.27.02.06.56	*Kasubag Umpeg*	*staf administrasi kurang cermat dalam pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Internal*	*C*	*Pembelian Tidak dapat diSPJKan*	*Dinas Kesehatan*
5.4.2	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Pelaksanaan*	*Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak sesuai DPA (Risiko Fraud)*	ROO.27.02.06.57	*Kasubag Umpeg*	*staf administrasi kurang cermat dalam pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Internal*	*C*	*Pembelian Tidak dapat diSPJKan*	*Dinas Kesehatan*
5.4.3	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*Pelaksanaan*	*Pembelian Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan tidak sesuai DPA (Risiko Fraud)*	ROO.27.02.06.58	*Kasubag Umpeg*	*staf administrasi kurang cermat dalam pembelian Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*Internal*	*C*	*Pembelian Tidak dapat diSPJKan*	*Dinas Kesehatan*
5.4.4	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*Pelaksanaan*	*Pembelian Makan Minuman Rapat Dobel kegiatan (Risiko Fraud)*	ROO.27.02.06.59	*Kasubag Umpeg*	*Kurangnya komunikasi antar staf administrasi kegiatan*	*Internal*	*C*	*Pembelian Tidak dapat diSPJKan*	*Dinas Kesehatan*
5.4.5	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*Pelaksanaan*	*Pembelian Barang Cetakan dan Penggandaan tidak sesuai DPA (Risiko Fraud)*	ROO.27.02.06.60	*Kasubag Umpeg*	*staf administrasi kurang cermat dalam pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Internal*	*C*	*Pembelian Tidak dapat diSPJKan*	*Dinas Kesehatan*
5.4.6	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*Pelaksanaan*	*Pembelian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan tidak sesuai DPA (Risiko Fraud)*	ROO.27.02.06.61	*Kasubag Umpeg*	*staf administrasi kurang cermat dalam pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Internal*	*C*	*Pembelian Tidak dapat diSPJKan*	*Dinas Kesehatan*
5.4.7	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Pelaksanaan*	*Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran (SPJ) Perjalanan Dinas tidak terverifikasi lengkap (Risiko Fraud)*	ROO.27.02.06.62	*Kasubag Umpeg*	*Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak membuat laporan*	*Internal*	*C*	*Berpotensi menjadi temuan pada saat pemeriksaan keuangan*	*Dinas Kesehatan*
5.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Risiko Fraud										
5.5.1	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*Pelaksanaan*	*Barang tidak sesuai dengan spesifikasi (Risiko Fraud)*	ROO.27.02.06.63	*Tim Pengadaan*	*Tim tidak cermat dalam membuat dokumen pengadaan*	*Internal*	*C*	*Berpotensi menjadi temuan pada saat pemeriksaan keuangan*	*Dinas Kesehatan*
5.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
5.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelaksanaan	Jasa Surat Menyurat melebihi pagu anggaran tiap bulannya	ROO.27.02.06.64	Kasubag Umpeg	staf administrasi tidak cermat dalam melaksanakan kegiatan	Internal	C	Tidak ada anggaran Jasa Surat Menyurat pada akhir tahun	Dinas Kesehatan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
5.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pelaksanaan	Pembayaran iuran telepon terlambat	ROO.27.02.06.65	Kasubag Umpeg	staf administrasi membayar tidak sesuai jadwal	Internal	C	pertanggungjawaban kegiatan terlambat	Dinas Kesehatan
5.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pelaksanaan	Tenaga outsoourcing tidak terbayar	ROO.27.02.06.66	Kasubag Umpeg	staf administrasi membayar tidak sesuai jadwal	Internal	C	pertanggungjawaban kegiatan terlambat	Dinas Kesehatan
5.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Risiko Fraud										
5.7.1	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*Pelaksanaan*	*Pemeliharaan kendaraan tidak sesuai dengan RKBMD Pemeliharaan (Risiko Fraud)*	ROO.27.02.06.67	*Kasubag Umpeg*	*staf administrasi tidak cermat dalam melaksanakan kegiatan*	*Internal*	*C*	*Berpotensi menjadi temuan pada saat pemeriksaan keuangan*	*Dinas Kesehatan*
5.7.2	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*Pelaksanaan*	*Adanya Mark Up Anggaran Pemeliharaan peralatan dan mesin (Risiko Fraud)*	ROO.27.02.06.68	*Kasubag Umpeg*	*kurangnya pengawasan dari penanggung jawab kegiatan*	*Internal*	*C*	*Berpotensi menjadi temuan pada saat pemeriksaan keuangan*	*Dinas Kesehatan*
5.7.3	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Pelaksanaan*	*Pemeliharaan Gedung Kantor tidak sesuai dengan spesifikasi (Risiko Fraud)*	ROO.27.02.06.69	*Kasubag Umpeg*	*Tim tidak cermat dalam membuat dokumen pemeliharaan*	*Internal*	*C*	*Berpotensi menjadi temuan pada saat pemeriksaan keuangan*	*Dinas Kesehatan*
5.7.4	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Pelaksanaan*	*Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak sesuai dengan spesifikasi (Risiko Fraud)*	ROO.27.02.06.70	*Kasubag Umpeg*	*Tim tidak cermat dalam membuat dokumen pemeliharaan*	*Internal*	*C*	*Berpotensi menjadi temuan pada saat pemeriksaan keuangan*	*Dinas Kesehatan*
	Risiko Pendapatan										
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan										
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya Yang Sejenis	-	*Pelaksanaan*	*Target pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya Yang Sejenis tidak tercapai*	ROO.27.02.06.71	*Kepala UPT Labkes*	*- Pelayanan kurang baik* *- Kunjungan pasien berkurang*	*Internal*	*C*	*Pendapatan APBD Kota Tegal berkurang*	*- Pemerintah Daerah* *- Dinas Kesehatan* *- Kepala UPT Labkes*
	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	-	*Pelaksanaan*	*Target pendapatan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah tidak tercapai*	ROO.27.02.06.72	*Kepala UPT Labkes*	*- Pelayanan kurang baik* *- Kunjungan pasien berkurang*	*Internal*	*C*	*Pendapatan APBD Kota Tegal berkurang*	*- Pemerintah Daerah* *- Dinas Kesehatan* *- Kepala UPT Labkes*
	Pendapatan dari BLUD Puskesmas dan KPM	-	*Pelaksanaan*	*Target pendapatan Pendapatan dari BLUD Puskesmas dan KPM tidak tercapai*	ROO.27.02.06.73	*Kepala Puskesmas Dan KPM*	*- Pelayanan kurang baik* *- Kunjungan pasien berkurang* *- Klaim dan Kapitasi BPJS Kesehatan berkurang*	*Internal*	*C*	*Belanja BLUD Berkurang*	*- Pemerintah Daerah* *- Dinas Kesehatan* *- Kepala Puskesmas Dan KPM*

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan
Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom f diisi dengan Kode risiko
Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan Material
Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko
Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Lampiran 5
Form 3.c

KERTAS KERJA
IDENTIFIKASI RISIKO PENANGANAN COVID-19

Nama Pemda	PEMERINTAH KOTA TEGAL
Nama OPD	DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL
Tahun Penilaian	2027
Periode yang dinilai	Periode Renstra Tahun 2026-2029
Tujuan Strategis	Terwujudnya Kesehatan Untuk Semua
Sasaran strategis OPD	Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Urusan Pemerintahan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
NIHIL											

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan
Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom f diisi dengan Kode risiko
Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan Material
Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko
Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Lampiran 5
Form 4

KERTAS KERJA
HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda	**PEMERINTAH KOTA TEGAL**
Tahun Penilaian	**2027**
Tujuan Strategis	**1. Tujuan 1.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah**
Urusan Pemerintahan	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	**Risiko Strategis (Form 3.a)**				
1	Peningkatan Beban Penyakit	RSP.27.02.06.01	2	2	7
2	Akses Pelayanan Kesehatan Terbatas	RSP.27.02.06.02	2	2	7
II	**Risiko Strategis OPD 1: Dinas Kesehatan (Form 3.b)**				
1	Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terbatas	RSO.27.02.06.01	4	1	6
2	Penumpukan dan keterlambatan pelayanan pasien	RSO.27.02.06.02	4	1	6
3	Penurunan Kualitas Perawatan	RSO.27.02.06.03	2	1	2
4	Keterlambatan ibu hamil dalam mendapatkan pelayanan K6	RSO.27.02.06.04	3	3	14
5	Meningkatknya risiko komplikasi persalinan	RSO.27.02.06.05	2	1	2
6	Ketidakakuratan data capaian pelayanan bayi baru lahir	RSO.27.02.06.06	2	1	2
7	Target pemantauan pertumbuhan balita tidak tercapai	RSO.27.02.06.07	2	2	7
8	Target pemeriksaan kesehatan peserta didik tidak tercapai	RSO.27.02.06.08	2	2	7
9	Target pemeriksaan kesehatan usia 15-59 tahun rendah	RSO.27.02.06.09	2	2	7
10	Target pemeriksaan kesehatan lansia tidak tercapai	RSO.27.02.06.10	2	2	7
11	Target pemeriksaan kesehatan penderita hipertensi tidak tercapai	RSO.27.02.06.11	2	2	7
12	Target pemeriksaan kesehatan penderita DM tdak tercapai	RSO.27.02.06.12	2	2	7
13	Target pemeriksaan penderita ODGJ tidak tercapai	RSO.27.02.06.13	2	2	7
14	Deteksi dini risiko TBC di masyarakat rendah	RSO.27.02.06.14	2	3	10
15	Target skrining HIV tidak tercapai	RSO.27.02.06.15	2	2	7
16	Target pemeriksaan kesehatan gratis tidak tercapai	RSO.27.02.06.16	2	2	7
17	Jumlah kematian ibu melebihi target yang telah ditetapkan	RSO.27.02.06.17	2	2	7
18	Jumlah kematian balita melebihi target yang telah ditetapkan	RSO.27.02.06.18	2	2	7
19	Target penurunan prevalensi gizi buruk tidak tercapai	RSO.27.02.06.19	3	3	14
20	Target penurunan prevalensi stunting tidak tercapai	RSO.27.02.06.20	2	2	7
21	Cakupan imunisasi bayi rendah	RSO.27.02.06.21	2	2	7
22	Kasus DBD di masyarakat tinggi	RSO.27.02.06.22	3	2	8
23	Tingkat penemuan kasus TBC baru secara aktif (Case Detection Rate) rendah	RSO.27.02.06.23	3	4	17
24	Penderita TBC tidak mengkonsumsi obat secara rutin	RSO.27.02.06.24	2	3	10
25	Meningkatnya kasus obesitas di masyarakat	RSO.27.02.06.25	2	2	7
26	Rendahnya penderita depresi yang mendapatkan layanan pengobatan	RSO.27.02.06.26	2	2	7
27	Menurunnya jumlah orang lajut usia yang datang ke pelayanan kesehatan	RSO.27.02.06.27	2	2	7
28	Meningkatnya jumlah penduduk 10-21 tahun yang merokok	RSO.27.02.06.28	2	2	7
29	Rendahnya persepsi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	RSO.27.02.06.29	2	1	2
30	Target penduduk yang mempunyai aktifitas fisik tidak tercapai	RSO.27.02.06.30	2	2	7
31	Kelurahan tidak lolos dalam verifikasi STBM	RSO.27.02.06.31	2	2	7
32	Target Tempat Pengelolaan Pangan tidak memenuhi syarat tidak tercapai	RSO.27.02.06.32	2	1	2
33	Target Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan tidak tercapai	RSO.27.02.06.33	2	2	7
34	Target fasilitas pelayanan kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional tidak tercapai	RSO.27.02.06.34	2	1	2
35	Hasil akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tidak mendapatkan strata paripurna	RSO.27.02.06.35	3	1	4
36	Perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tidak memenuhi persyaratan ASPAK	RSO.27.02.06.36	2	2	7
37	Tenaga kesehatan tidak dapat mengikuti uji kompetensi	RSO.27.02.06.37	2	1	2
38	Penyebaran tenaga kesehatan tidak merata	RSO.27.02.06.38	2	2	7
39	Terget puskesmas dengan SDMK sesuai standar tidak terpenuhi	RSO.27.02.06.39	2	2	7
40	Tidak terpenuhi jenis dan jumlah dokter spesialis di RS pemerintah	RSO.27.02.06.40	2	2	7
41	Masih ditemukan sarana kesehatan tidak memenuhi standar kefarmasian (Lemahnya penerapan sistem pengelolaan stok)	RSO.27.02.06.41	2	2	7
42	Tempat pengelolaan Makanan (TPM) yang tidak dapat memenuhi syarat dalam pengelolaan makanan	RSO.27.02.06.42	2	2	7
43	Pemenuhan komitmen oleh sarana IRTP tidak optimal (kesulitan mengakses dan mengoperasikan sistem aplikasi)	RSO.27.02.06.43	2	2	7
44	Kurangnya konsistensi penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) oleh P-IRT	RSO.27.02.06.44	2	2	7
45	IRTP tidak dapat memenuhi persyaratan LSHS	RSO.27.02.06.45	2	2	7
46	Target apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan tidak memuhi target	RSO.27.02.06.46	2	2	7
47	Hasil rekomendasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	RSO.27.02.06.47	2	2	7
48	Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat	RSO.27.02.06.48	2	2	7
49	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan menurun dari tahun sebelumya	RSO.27.02.06.49	2	2	7
50	Indeks kematangan organisasi Dinkes Kesehatan menurun dari tahun sebelumnya	RSO.27.02.06.50	2	2	7

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
III	**Risiko Operasional OPD 1: Dinas Kesehatan (Form 3.c)**				
1	Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan tidak terpelihara dengan baik	ROO.27.02.06.01	2	1	2
2	Proses pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan tidak sesuai DPA (Risiko Fraud)	ROO.27.02.06.02	2	1	2
3	Rendahnya pengetahuan ibu hamil/keluarga tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan dan jadwalnya	ROO.27.02.06.03	2	1	2
4	Kekurangan Kompetensi Tenaga Kesehatan	ROO.27.02.06.04	2	1	2
5	Tidak dilakukan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) tidak terhadap anak baru lahir	ROO.27.02.06.05	3	2	8
6	Rendahnya Kunjungan Balita ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan	ROO.27.02.06.06	3	2	8
7	Partisipasi sekolah dalam pemeriksaan berkala atau penjaringan anak sekolah rendah	ROO.27.02.06.07	3	1	4
8	- Tidak dapat dilakukan skrining risiko PTM pada usia produtif - Posbindu Remaja tidak dapat dilaksanakan	ROO.27.02.06.08	3	1	4
9	Posyandu lansia tidak dapat terlaksana	ROO.27.02.06.09	2	3	10
10	Masyarakat yang berkunjung ke pelayanan kesehatan tidak dilakukan skrining faktor risiko penyakit tidak menular khususnya hipertensi	ROO.27.02.06.10	2	2	7
11	Masyarakat yang berkunjung ke pelayanan kesehatan tidak diperiksaan kadar gula darah	ROO.27.02.06.11	2	1	2
12	Penderita ODGJ tidak berobat dan tidak minum obat secara rutin	ROO.27.02.06.12	2	4	13
13	Penemuan kasus aktif TB (Case Finding) rendah	ROO.27.02.06.13	3	2	8
14	Tidak dapat melakukan Test HIV/AIDS	ROO.27.02.06.14	3	2	8
15	Penyakit potensial wabah tidak terpantau dengan baik	ROO.27.02.06.15	2	2	7
16	a. Penderita Gizi Buruk tidak mendapat Pelayanan / Perawatan yang optimal b. Bantuan PMT tidak dikonsumsi oleh penderita c. Kualitas PMT yang kurang baik d. Pemberian PMT tidak berkelanjutan atau jumlah pemberian tidak sesuai volume yang seharusnya diperoleh penderita	ROO.27.02.06.16	2	2	7
17	Tidak ada dokumen hasil studi penilaian risiko kesehatan lingkungan	ROO.27.02.06.17	2	2	7
18	Tidak Terbentuknya Asman TOGA, Kegiatan Asman TOGA Berhenti, Tidak Tersedianya Lahan untuk budi daya TOGA	ROO.27.02.06.18	2	2	7
19	a. Bayi dan balita tidak mendapatkan imunisasi lengkap, b. Keluarga takut anaknya sakit setelah diimunisasi c. Terbatasnya stok vaksin tertentu di tingkat pusat hingga ke daerah	ROO.27.02.06.19	2	2	7
20	Iur Premi BPJS Kesehatan PBI APBD II terlambat	ROO.27.02.06.20	2	2	7
21	Penduduk Maskin tidak terlayani kesehatannya karena tidak ada biaya	ROO.27.02.06.21	2	2	7
22	Dokumen tatanan Kota Sehat tidak tersedia dengan lengkap	ROO.27.02.06.22	3	1	4
23	Keterbatasan informasi ketersediaan ruang rawat di Fasyankes	ROO.27.02.06.23	2	2	7
24	Monitoring dan pembinaan pasca akreditasi tidak dilakukan	ROO.27.02.06.24	2	2	7
25	Tidak dketahui penyebab kasus kejadian KIPI berdasarkan kajian medis	ROO.27.02.06.25	2	2	7
26	Kapasitas dan kemampuan petugas dalam pelayanan SPGDT kurang memadai	ROO.27.02.06.26	2	2	7
27	Penderita TB tidak memperoleh PMT untuk perbaikan gizi	ROO.27.02.06.27	2	2	7
28	Penderita HIV / AIDS tidak mendapatkan dukungan dan motivasi dari sesama penderita HIV / AIDS	ROO.27.02.06.28	2	2	7
29	Kasus malaria di rumah sakit tidak dilaporkan	ROO.27.02.06.29	2	2	7
30	Masih tingginya ibu hamil risiko tinggi	ROO.27.02.06.30	2	2	7
31	Bayi dan balita tidak mendapatkan imunisasi lengkap	ROO.27.02.06.31	4	2	12
32	Tidak terselenggaranya pemeriksaan kesehatan haji bagi calon jamaah haji	ROO.27.02.06.32	2	2	7
33	Perusahaan / pekerja tidak berpartisipasi dalam K3	ROO.27.02.06.33	3	1	4
34	Penderita ODGJ tidak berobat - Penderita ODGJ tidak minum obat secara rutin	ROO.27.02.06.34	3	1	4
35	a. Ibu Hamil tidak memeriksakan kesehatannya b. Kurang validnya data pemeriksaan ibu hamil bahwa bumil pernah / blm di screening hepatitis B	ROO.27.02.06.35	2	1	2
36	- Tidak dapat dilakukan skrining risiko PTM pada usia produtif - Posbindu Remaja tidak dapat dilaksanakan	ROO.27.02.06.36	2	1	2
37	Terjadinya insiden keselamatan pasien, seperti salah diagnosis, kesalahan pemberian obat (medication error), atau komplikasi penanganan medis akibat ketidakpatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP)	ROO.27.02.06.37	2	1	2
38	Tidak dilakukan skrining NAPZA untuk masyarakat dan anak sekolah	ROO.27.02.06.38	2	1	2
39	SIMPUS tidak dapat diakses	ROO.27.02.06.39	4	3	16
40	Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak teregistrasi perizinannya di Kementerian Kesehatan	ROO.27.02.06.40	2	1	2
41	Fasilitas pelayanan Kesehatan tidak menigrimkan laporan indikator mutu ke Kemkes	ROO.27.02.06.41	3	1	4
42	Puskesmas, Pustu dan Posyandu ILP tidak berjalan	ROO.27.02.06.42	3	2	8
43	Puskesmas, Pustu dan Posyandu ILP tidak berjalan	ROO.27.02.06.43	2	2	7
44	Tenaga Kesehatan tidak dapat mengikuti Uji Kompetensi	ROO.27.02.06.44	3	1	4
45	Pangan yang beredar tidak memiliki Ijin edar (SPPIRT)	ROO.27.02.06.45	3	1	4
46	TPM tidak memiliki ijin Laik Hygiene Sanitasi	ROO.27.02.06.46	2	1	2
47	Pangan yang beredar tidak tidak aman dan tidak sehat	ROO.27.02.06.47	2	1	2
48	Tidak optimalnya pokjanal Posyandu dan Forum Kesehatan Kelurahan	ROO.27.02.06.48	2	1	2

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
49	a. Tidak tersedianya data PHBS rumah tangga yang akurat. b. Tidak terselenggaranya kegiatan promosi kesehatan (media cetak, penyuluhan langsung, siaran radio) kepada masyarakat c. Terkendalanya gerakan masyarakat hidup sehat	ROO.27.02.06.49	3	1	4
50	a. Kegiatan upaya kesehatan berbasis masayarakat /UKBM (Posyandu, Posbindu, Poslansia dll) tidak berjalan b. Masyarakat tidak berkunjung ke Pos UKBM	ROO.27.02.06.50	3	1	4
51	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terlambat disusun	ROO.27.02.06.51	2	1	2
52	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlambat disusun	ROO.27.02.06.52	2	1	2
53	Dokumen gaji pegawai tidak sesuai	ROO.27.02.06.53	2	1	2
54	Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran (SPJ) tidak terverifikasi lengkap	ROO.27.02.06.54	2	1	2
55	Laporan BMD belum sesuai kondisi yang ada	ROO.27.02.06.55	2	1	2
56	Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak sesuai DPA (Risiko Fraud)	ROO.27.02.06.56	3	1	4
57	Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak sesuai DPA (Risiko Fraud)	ROO.27.02.06.57	2	1	2
58	Pembelian Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan tidak sesuai DPA (Risiko Fraud)	ROO.27.02.06.58	2	1	2
59	Pembelian Makan Minuman Rapat Dobel kegiatan (Risiko Fraud)	ROO.27.02.06.59	2	1	2
60	Pembelian Barang Cetakan dan Penggandaan tidak sesuai DPA (Risiko Fraud)	ROO.27.02.06.60	2	1	2
61	Pembelian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan tidak sesuai DPA (Risiko Fraud)	ROO.27.02.06.61	2	1	2
62	Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran (SPJ) Perjalanan Dinas tidak terverifikasi lengkap (Risiko Fraud)	ROO.27.02.06.62	2	1	2
63	Barang tidak sesuai dengan spesifikasi (Risiko Fraud)	ROO.27.02.06.63	2	1	2
64	Jasa Surat Menyurat melebihi pagu anggaran tiap bulannya	ROO.27.02.06.64	2	1	2
65	Pembayaran iuran telepon terlambat	ROO.27.02.06.65	2	1	2
66	Tenaga outsoourcing tidak terbayar	ROO.27.02.06.66	2	1	2
67	Pemeliharaan kendaraan tidak sesuai dengan RKBMD Pemeliharaan (Risiko Fraud)	ROO.27.02.06.67	2	1	2
68	Adanya Mark Up Anggaran Pemeliharaan peralatan dan mesin (Risiko Fraud)	ROO.27.02.06.68	2	1	2
69	Pemeliharaan Gedung Kantor tidak sesuai dengan spesifikasi (Risiko Fraud)	ROO.27.02.06.69	2	1	2
70	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak sesuai dengan spesifikasi (Risiko Fraud)	ROO.27.02.06.70	2	1	2
71	Target pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya Yang Sejenis tidak tercapai	ROO.27.02.06.71	2	1	2
72	Target pendapatan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah tidak tercapai	ROO.27.02.06.72	2	1	2
73	Target pendapatan Pendapatan dari BLUD Puskesmas dan KPM tidak tercapai	ROO.27.02.06.73	2	1	2
IV	**Risiko Penanganan Covid-19 (Form 3.d kalau ada)**				

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dngan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b
Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b
Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rataa-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi
Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi
Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Lampiran 5
Form 5

KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO PRIORITAS

Nama Pemda	**PEMERINTAH KOTA TEGAL**
Tahun Penilaian	**2027**
Tujuan Strategis	**1. Tujuan 1.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah** **2. Tujuan 3.1 Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**
Urusan Pemerintahan	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	**Risiko Strategis (3.a)**					
II	**Risiko Strategis OPD (3.b)**					
1	Keterlambatan ibu hamil dalam mendapatkan pelayanan K6	RSO.27.02.06.04	14	Kepala Dinas Kesehatan	Ibu hamil tidak mempunyai pembiayaan untuk megakses layanan kesehatan	Risiko kematian ibu tinggi
2	Target penurunan prevalensi gizi buruk tidak tercapai	RSO.27.02.06.19	14	Kepala Dinas Kesehatan	Rendahnya pola asuh orang tua, kondisi lingkungan yang buruk, sosial ekonomi keluarga rendah, penyakit kronis / bawaan pada anak	Pertumbuhan fisik dan perkembangan mental balita terganggu
3	Tingkat penemuan kasus TBC baru secara aktif (Case Detection Rate) rendah	RSO.27.02.06.23	17	Kepala Dinas Kesehatan	Fasyankes tidak melakukan skrining TBC, penggerakan masyarakat untuk pemeriksaan TBC rendah, tidak tersedia peralatan dan perlengkapan skrining TBC	Peningkatan penularan kasus TBC di masyarakat
III	**Risiko Operasional OPD (3.c)**					
4	Penderita ODGJ tidak berobat dan tidak minum obat secara rutin	ROO.27.02.06.12	13	Kepala Bidang UKMP	a. Keluarga penderita kurang / tidak kooperatif b. Terbatasnya fasilitas kesehatan c. Diskriminasi dalam Kelg / Masy d. Terbatasnya Tenaga Kesahatan terlatih Kesehatan Jiwa	a. Terganggunya kesejahteraan keluarga / Beban Ekonomi b. Keresahan Masyarakat c. Produktifitas Penderita menurun d. Memperberat kondisi kesehatan jiwa penderita
5	Bayi dan balita tidak mendapatkan imunisasi lengkap	ROO.27.02.06.31	12	Kepala Bidang UKMP	1. masih terdapat penolakan imunisasi di masyarakat karena berbagai sebab, antara lain isu hoax, kurangnya pengetahuan masyarakat ttg imunisasi, kepercayaan antivaks, dll 2. sistem pendataan sasaran imunisasi kurang kuat (terdapat Puskesmas yg blm mempunyai data sasaran imunisasi yg ada di wilayahnya) 3. terdapat gap cakupan imunisasi secara manual dan secara aplikasi ASIK antara lain disebabkan sistem pencatatan dan pelaporan hasil imunisasi di ASIK tdk real time, aplikasi ASIK sering maintenance, dan tdk lengkapnya data yang akan diinput ke dalam aplikasi	a. Anak yang tidak diimunisasi lebih berisiko terkena penyakit menular b. Target IDL tidak tercapai c. Dapat terjadi KLB
6	SIMPUS tidak dapat diakses	ROO.27.02.06.39	16	Kepala Bidang Fsyankes	Server SIMPUS down	Pasien tidak mendapat layanan kesehatan dengan cepat dan akurat
IV	**Risiko Penanganan Covid-19 (Form 3.d kalau ada)**					

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko prioritas
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)
Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b
Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b
Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

Lampiran 5
Form 7

PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN
(RTP ATAS HASIL IDENTIFIKASI RISIKO)

Nama Pemda	**PEMERINTAH KOTA TEGAL**
Tahun Penilaian	**2027**
Tujuan Strategis	**1. Tujuan 1.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah**
Urusan Pemerintahan	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangungg Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	**Risiko Strategis (3.a)**						
II	**Risiko Strategis OPD (3.b)**						
1	Keterlambatan ibu hamil dalam mendapatkan pelayanan K6	RSO.27.02.06.04	- ANC Terpadu - Pemberian PMT Ibu hamil - Melakukan Skrining SHK - Jaminan biaya kesehatan bagi keluarga tidak mampu - Kunjungan Ibu hamil risiko tinggi - Menyediakan puskesmas mampu persalinan dan RS rujukan PONEK - USG di puskesmas - Pendampingan dokter spesialis kandungan (SPOG) dan dokter speasialisa anak (SPA) - Pendampingan rujukan Ibu hamil risiko tinggi dan neonatal risti - Gerakan Ibu Hamil Sehat	Belum optimalnya kelas ibu hamil	Penguatan pelaksanaan kelas ibu hamil	Kepala Bidang; Kepala Dinas Kesehatan	Triwulan II, III, IV Tahun 2027
2	Target penurunan prevalensi gizi buruk tidak tercapai	RSO.27.02.06.19	- Pencatatan dan validasi data balita gizi buruk - Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita - Pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan - Kunjungan Rumah balita gizi buruk - Pembiayaan bagi keluarga tidak mampu - Melakukan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) bagi Anak Balita	Rendahnya pola asuh orang tua	Konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	Kepala Bidang; Kepala Dinas Kesehatan	Triwulan II, III, IV Tahun 2027
3	Tingkat penemuan kasus TBC baru secara aktif (Case Detection Rate) rendah	RSO.27.02.06.23	- Penemuan kasus aktif TB - Pemberian PMT penderita TB - Kader Pandamping Minum Obat (PMO) - Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Petugas Lab - Skrining TB di layanan kesehatan - Pengobatan pasien TB - Peningkatan layanan puskesmas bagi TB RO - Pembentukan Kelompok Peduli TB - Pendampingan pasien TBC	Pemeriksaan TBC di masyarakat masih rendah	Pemeriksaan TBC di masyarakat secara aktif	Kepala Bidang; Kepala Dinas Kesehatan	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2027

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangungg Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
III	**Risiko Operasional OPD (3.c)**						
4	Penderita ODGJ tidak berobat dan tidak minum obat secara rutin	ROO.27.02.06.12	- Sosialisasi kesehatan jiwa - Deteksi Dini dan skrining kesehatan jiwa - Kunjungan Rumah kasus ODGJ - Pengobatan rutin pasien ODGJ - Penemuan kasus ODGJ baru - Pengiriman kasus ODGJ ke Rumah Sakit Rujukan - Pembuatan KIS bagi ODGJ yang tidak mempunyai JKN	Perlu orang terdekat baik keluarga atau tetangga yang mendampingi untuk berobat dan minum obat	Pendamping Minum Obat (PMO) bagi ODGJ	Kepala Bidang; Kepala Dinas Kesehatan	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2027
5	Bayi dan balita tidak mendapatkan imunisasi lengkap	ROO.27.02.06.31	1. Sosialisasi imunisasi dg berbagai media 2. Sosialisasi imunisasi melalui kegiatan kampanye imunisasi 3. Koordinasi dg disdukcapil terkait data sasaran imunisasi 4. Koordinasi dan pemantauan secara berkala terhadap hasil inputan ASIK 5. Advokasi kepada kepala puskesmas untuk membentuk tim khusus input data di ASIK Imunisasi 6. Renval dan PWS imunisasi secara berkala	Meningkatkan kunjungan rumah untuk sweeping imunisasi	Sweeping rutin imunisasi bayi dan balita di masyarakat	Kepala Bidang; Kepala Dinas Kesehatan	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2027
6	SIMPUS tidak dapat diakses	ROO.27.02.06.39	- Penyambungan jaringan FO - Penyambungan jaringan internet dari provider lain - Maintenance berkala server - Pengelolaan CPanel - Update SIMPUS - Perbaikan jaringan (LAN) - Melakukan Indexing tabel	Belum dilakukan monitoring secara keseluruhan baik server tegalkota, server bridging BPJS dan server Satusehat	Melakukan monitoring server tegalkota, bridging BPJS dan Satusehat secara berkala	Kepala Bidang; Kepala Dinas Kesehatan	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2027
IV	**Risiko Penanganan Covid-19**						
1							
2							

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko prioritas
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.
Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:
(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan
Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Lampiran 5
Form 8

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda	**PEMERINTAH KOTA TEGAL**
Tahun Penilaian	**2027**
Tujuan Strategis	**1. Tujuan 1.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah**
Urusan Pemerintahan	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penguatan pelaksanaan kelas ibu hamil	Pertemuan	Dinas Kesehatan	Ibu hamil	Triwulan II, III, IV Tahun 2027		
2	Konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	Konseling	Dinas Kesehatan	Orang Tua Bayi / Balita	Triwulan II, III, IV Tahun 2027		
3	Pemeriksaan TBC di masyarakat secara aktif	Pemeriksaan	Dinas Kesehatan	Masyarakat	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2027		
4	Pendamping Minum Obat (PMO) bagi ODGJ	Petemuan	Dinas Kesehatan	Keluarga Penderita ODGJ	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2027		
5	Sweeping rutin imunisasi bayi dan balita di masyarakat	Kunjungan Rumah	Dinas Kesehatan	Orang Tua Bayi / Balita	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2027		
6	Melakukan monitoring server tegalkota, bridging BPJS dan Satusehat secara berkala	Monitoring	Dinas Kesehatan	Pemegang Program SIK	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2027		

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

Lampiran 5
Form 9

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda	**PEMERINTAH KOTA TEGAL**
Tahun Penilaian	**2027**
Tujuan Strategis	**1. Tujuan 1.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah**
Urusan Pemerintahan	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
I	**Risiko Strategis (3.a)**					
II	**Risiko Strategis OPD (3.b)**					
1	Penguatan pelaksanaan kelas ibu hamil	Monitoring Dan Evaluasi	Kepala Bidang UKMP	Triwulan II, III, IV Tahun 2027		
2	Konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	Monitoring Dan Evaluasi	Kepala Bidang UKMP	Triwulan II, III, IV Tahun 2027		
3	Pemeriksaan TBC di masyarakat secara aktif	Monitoring Dan Evaluasi	Kepala Bidang UKMP	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2027		
III	**Risiko Operasional OPD (3.c)**					
4	Pendamping Minum Obat (PMO) bagi ODGJ	Monitoring Dan Evaluasi	Kepala Bidang UKMP	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2027		
5	Sweeping rutin imunisasi bayi dan balita di masyarakat	Monitoring Dan Evaluasi	Kepala Bidang Fasyankes	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2027		
6	Melakukan monitoring server tegalkota, bridging BPJS dan Satusehat secara berkala	Monitoring Dan Evaluasi	Kepala Bidang Fasyankes	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2027		
IV	**Risiko Penanganan Covid-19**					
1						
2						

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya.

Lampiran 5
Form 10

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda	**PEMERINTAH KOTA TEGAL**
Tahun Penilaian	**2027**
Tujuan Strategis	**1. Tujuan 1.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah**
Urusan Pemerintahan	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	**Risiko Strategis (3.a)**									
II	**Risiko Strategis OPD (3.b)**									
1	Keterlambatan ibu hamil dalam mendapatkan pelayanan K6	RSO.27.02.06.04		Ibu hamil tidak mempunyai pembiayaan untuk megakses layanan kesehatan	Risiko kematian ibu tinggi		Penguatan pelaksanaan kelas ibu hamil	Triwulan II, III, IV Tahun 2027		
2	Target penurunan prevalensi gizi buruk tidak tercapai	RSO.27.02.06.19		Rendahnya pola asuh orang tua, kondisi lingkungan yang buruk, sosial ekonomi keluarga rendah, penyakit kronis / bawaan pada anak	Pertumbuhan fisik dan perkembangan mental balita terganggu		Konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	Triwulan II, III, IV Tahun 2027		
3	Tingkat penemuan kasus TBC baru secara aktif (Case Detection Rate) rendah	RSO.27.02.06.23		Fasyankes tidak melakukan skrining TBC, penggerakan masyarakat untuk pemeriksaan TBC rendah, tidak tersedia peralatan dan perlengkapan skrining TBC	Peningkatan penularan kasus TBC di masyarakat		Pemeriksaan TBC di masyarakat secara aktif	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2027		
III	**Risiko Operasional OPD (3.c)**									
4	Penderita ODGJ tidak berobat dan tidak minum obat secara rutin	ROO.27.02.06.12		a. Keluarga penderita kurang / tidak kooperatif b. Terbatasnya fasilitas kesehatan c. Diskriminasi dalam Kelg / Masy d. Terbatasnya Tenaga Kesahatan terlatih Kesehatan Jiwa	a. Terganggunya kesejahteraan keluarga / Beban Ekonomi b. Keresahan Masyarakat c. Produktifitas Penderita menurun d. Memperberat kondisi kesehatan jiwa penderita		Pendamping Minum Obat (PMO) bagi ODGJ	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2027		
5	Bayi dan balita tidak mendapatkan imunisasi lengkap	ROO.27.02.06.31		1. masih terdapat penolakan imunisasi di masyarakat karena berbagai sebab, antara lain isu hoax, kurangnya pengetahuan masyarakat ttg imunisasi, kepercayaan antivaks, dll 2. sistem pendataan sasaran imunisasi kurang kuat (terdapat Puskesmas yg blm mempunyai data sasaran imunisasi yg ada di wilayahnya) 3. terdapat gap cakupan imunisasi secara manual dan secara aplikasi ASIK antara lain disebabkan sistem pencatatan dan pelaporan hasil imunisasi di ASIK tdk real time, aplikasi ASIK sering maintenance, dan tdk lengkapnya data yang akan diinput ke dalam aplikasi	a. Anak yang tidak diimunisasi lebih berisiko terkena penyakit menular b. Target IDL tidak tercapai c. Dapat terjadi KLB		Sweeping rutin imunisasi bayi dan balita di masyarakat	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2027		
6	SIMPUS tidak dapat diakses	ROO.27.02.06.39		Server SIMPUS down	Pasien tidak mendapat layanan kesehatan dengan cepat dan akurat		Melakukan monitoring server tegalkota, bridging BPJS dan Satusehat secara berkala	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2027		

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS KESEHATAN
JL. Proklamasi 16 Tegal Nomor Telp/Fax (0283) 353351 Kode Pos 52111
Email : dinkeskotategal@yahoo.co.id / dinkeskotategal@depkes.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL
NOMOR : 200 . 1 / 011

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM UNIT PEMILIK RISIKO
DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL TAHUN 2027

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Tegal, perlu membentuk Unit Pemilik Risiko;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahu 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang.....

8. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 1419 Tahun 2021);

13. Permenkes No. 6 Tahun 2024 adalah Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal tahun 2009 Nomor 1);

17. Peraturan Walikota Tegal Nomor 81 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kota Tegal;

18. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5);

20. Peraturan.....

19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2023 Nomor 34)

20. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pemilik Resiko pada Dinas Kesehatan Kota Tegal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Unit Pemilik Risiko bertujuan membantu Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Tegal;

KETIGA : Tugas Pokok Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, adalah sebagai berikut :

1. Unit Pemilik Risiko Eselon II, memiliki tugas :
   a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota Tegal;
   b. menyusun rencana kerja dan strategi pengelolaan risiko tingkat unit eselon II di Dinas Kesehatan Kota Tegal;
   c. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
   d. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
2. Unit Pemilik Risiko Eselon III, memiliki tugas :
   a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran program tingkat unit eselon III di Dinas Kesehatan Kota Tegal;
   b. menyusun rencana kerja dan strategi pengelolaan risiko tingkat unit eselon III di Dinas Kesehatan Kota Tegal;
   c. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analissi risiko tingkat unit eselon III di Dinas Kesehatan Kota Tegal; dan
   d. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
3. Unit Pemilik Risiko Eselon IV, memiliki tugas :
   a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran program tingkat unit eselon IV di Dinas Kesehatan Kota Tegal;

b. menyusun.....

b. menyusun rencana kerja dan strategi pengelolaan risiko tingkat unit eselon IV di Dinas Kesehatan Kota Tegal;

c. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analissi risiko tingkat unit eselon IV di Dinas Kesehatan Kota Tegal; dan

d. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

KEEMPAT : Masa Kerja Unit Pemilik Risiko Dinas Kesehatan Kota Tegal adalah selama 1 (satu) tahun sejak keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal Tahun Anggaran 2027.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tegal
Pada tanggal : 18 September 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TEGAL

M. ZAENAL ABIDIN

Tembusan :
1. Segenap Tim Unit Pemilik Risiko Dinas Kesehatan Kota Tegal Tahun 2027;
2. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KOTA TEGAL
NOMOR : 700.1/011
TANGGAL : 18 September 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM UNIT PEMILIK RISIKO
DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL TAHUN 2027

NO	NAMA NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
A.	UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON II		
1	M. ZAENAL ABIDIN, SKM, MM NIP. 196805141988011001	Kepala	Ketua
2	dr. SRI RETNO HENDRAWATI, MM NIP. 197007122002122003	Sekretaris	Koordinator Teknis merangkap Anggota
3	WIHARTO, S.Kep, M.Kes NIP. 196811291989031003	Kepala Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Perorangan	Anggota
4	dr. INKA ROEKMIASRI NIP. 196907302006042002	Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
5	SUPANDI, ST,MPH NIP. 197210172002121007	Kepala Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehata	Anggota
6	DIAH SEPTIYANINGSIH, S.Kep, Ns., M.M NIP. 198609032009032004	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Anggota
7	MIFTACHUDIN, SKM, MM NIP. 197403092005011006	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan	Anggota
B.1	UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON III (Sekretaris)		
1	dr. SRI RETNO HENDRAWATI, MM NIP. 197007122002122003	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua
2	MIFTACHUDIN, SKM, MM NIP. 197403092005011006	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan	Koordinator Teknis merangkap Anggota
3	DIAH SEPTIYANINGSIH, S.Kep, Ns., M.M NIP. 198609032009032004	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Anggota
4	RIWANTO, SKM NIP. 198107272010011023	Staff Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan	Anggota
5	WINDI PRASETYO, SE, M.Si NIP. 198405242010011025	Staff Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Anggota

NO	NAMA NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
B.2	UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON III (BIDANG UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERORANGAN)		
1	WIHARTO, S.Kep, M.Kes NIP. 196811291989031003	Kepala Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Perorangan	Ketua
2	TARYULI, S.Keb, BDN, MM NIP. 198104012006042012	Bidan Ahli Muda Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Perorangan	Koordinator Teknis merangkap Anggota
3	RINI LINGGARWATI, SKM NIP. 197204031994022002	Administrator Kesehatan Ahli Muda Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Perorangan	Anggota
4	PURWO HADI SUTINI, S.ST. NIP. 197105151994032006	Nutrisionis Ahli Madya Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Perorangan	Anggota
5	SRI SUKESIH, SKM NIP. 19780525 200501 2 012	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Perorangan	Anggota
6	NURKHOLIFAH, S.K.M NIP. 19800615 200501 2 016	Bidan Terampil Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Perorangan	Anggota
7	HARYANTI, S.Kep NIP. 19850317 201101 2 013	Perawat Terampil Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Perorangan	Anggota
8	ULFA HASANAH, SKM NIP. 19840408 201001 2 030	Sanitarian Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Perorangan	Anggota
9	SATRIA PUTRA ARBAIN, A.Md.T NIP. 19960323 202221 1 001	Pranata Komputer Terampil Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Perorangan	Anggota
10	TEGUH RIYADI, S.KM NIP. 19940315 202321 1 005	Epidemiolog Kesehatan Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Perorangan	Anggota
B.3	UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON III (BIDANG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN)		
1	SUPANDI, ST,MPH NIP. 197210172002121007	Kepala Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Ketua
2	MULYANTO, SKM NIP. 197212131997021001	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Koordinator Teknis merangkap Anggota
3	FAJRIYAH, SKM NIP. 19750808201001 2013	Sanitarian Ahli Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Anggota

NO	NAMA NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
4	RAISAH, A.Md.Kep, S.Kep NIP. 197708012006042012	Administrator Kesehatan Ahli Muda Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Anggota
5	HENNY HASLIANA, S.Kep NIP. 19800913 200701 2 004	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Anggota
6	EKA SULISTIANI, S.K.M NIP. 19880816 200912 2 001	Sanitarian Ahli Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Anggota
7	SISWOYO, M.Kom NIP. 19790610 200903 1 004	Pranata Komputer Ahli Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Anggota
8	IKHDA MUNAWAROH, S.Farm NIP. 19840808 200903 2 005	Asisten Apoteker Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Anggota
B.4	UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON III (BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN)		
1	dr. INKA ROEKMIASRI NIP. 196907302006042002	Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
2	ETI PURWANINGSIH, SKM NIP. 198508232010012032	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan	Koordinator Teknis merangkap Anggota
3	BAMBANG SISWOYO, SKM NIP. 197407111997031003	Administrator Kesehatan Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
4	ATIQ HARKATI, SKM., M.P.H NIP. 19830731 200903 2 003	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
5	RIYANI, A.Md NIP. 19841213 201101 2 009	Prana Komputer Terampil Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
C.1	UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON IV (SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN)		
1	MIFTACHUDIN, SKM, MM NIP. 197403092005011006	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan	Ketua
2	RIZKA EMAN YULISTIANTI, S.ST NIP. 19880723 2010012015	Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan	Koordinator Teknis Merangkap anggota
3	ARWINDA SUPRIYATNI, A.Md NIP. 198901182011012008	Bendahara Pegeluaran	Anggota

NO	NAMA NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
4	FANI ISKANDAR, S.KOM NIP. 19860308 202321 1 016	Pranata Komputer Ahli Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan	Anggota
5	MASLAKHATUL LUTFIYAH, A.Md NIP. 19820303 201001 2 022	Bendahara Penerimaan	Anggota
C.2	UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON IV (SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN)		
1	DIAH SEPTIYANINGSIH, S.Kep, Ns., M.M NIP. 198609032009032004	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Ketua
2	WINDI PRASETYO, SE, M.Si NIP. 198405242010011025	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	Koordinator Teknis Merangkap anggota
3	AZIZ PUTRA PURNOMO, A.MD.KOM NIP. 19890509 202321 1 023	Pranata Komputer Terampil Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Anggota
4	SANDI SAPUTRO, S.KOM NIP. 19860130 202321 1 012	Pranata Komputer Ahli Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Anggota
5	ELISA ACHIRIA YULIANI NIP. 19800731 202521 2 012	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Anggota
6	CHUMAEDAH, A.Md NIP. 19880606 201101 2 019	Pranata Komputer Ahli Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Anggota
7	YUSTINA WIRASTUTI, S.IP NIP. 19801122 201101 2 008	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Anggota

Ditetapkan di : Tegal
Pada tanggal : 18 September 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TEGAL

M. ZAENAL ABIDIN